

I- Sémiologie:

1- Sémiologie générale

Question	réponse
Il n'y a pas de QCSs à ce cours dans les examens disponibles	

2- Fièvre

Question 1 : 1. Les causes infectieuses localisées de la fièvre :

(Dr Kahel,2024,2025)

- 1) Pneumonie.
- 2) Tuberculeuse.
- 3) Endocardite infectieuse.
- 4) Ostéomyélite.
- 5) Fièvre typhoïde

- A. 1.2
- B. 4.5
- C. 1.2.3.4.5
- D. 1.3.4
- E. 3.4.5

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La tuberculose (2) est une infection spécifique bactérienne, pas une infection localisée.
- **B : Faux** — La fièvre typhoïde (5) est une infection spécifique bactérienne, pas une infection localisée.
- **C : Faux** — Inclut la tuberculose (2) et la fièvre typhoïde (5) qui ne sont pas des infections localisées.
- **D : Vrai** — Selon le tableau de la page 29, les infections localisées sont : Pyélonéphrite aiguë, Pneumonie (1), Abscess, Rhinosinusite aiguë, Ostéomyélite (4), Endocardite infectieuse (3).
- **E : Faux** — Inclut la fièvre typhoïde (5) qui n'est pas une infection localisée.

Question 2 : L'analyse de la courbe thermique peut nous renseigner et donne :

(Dr Kahel,2025)

- A. La fièvre en plateau peut se voir dans le paludisme.
- B. La fièvre ondulante on peut se voir dans la tuberculose
- C. La fièvre intermittente en plateau peut se voir dans la brucellose.
- D. La fièvre rémittente quotidienne se voit dans les suppurations profondes
- E. Le fébricule qu'on peut le trouver dans la septicémie.

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La fièvre en plateau se voit dans la fièvre typhoïde, les septicémies, l'endocardite et le paludisme de primo-invasion (page 20 dans le cours de prof), mais le paludisme typique est intermittent. Cependant, cette option est partiellement vraie mais pas la meilleure réponse car D est plus précise.
- **B : Faux** — La fièvre ondulante se voit dans la maladie de Hodgkin et la brucellose (page 25), pas dans la tuberculose. La tuberculose donne une fébricule (page 26).
- **C : Faux** — La fièvre intermittente n'est pas "en plateau". La brucellose donne une fièvre ondulante (page 25).
- **D : Vrai** — La fièvre rémittente quotidienne : température matinale sub-normale, élévation vespérale à 39-40°C, se voit dans les suppurations profondes et la péritonite (page 21).
- **E : Faux** — Le fébricule est un décalage thermique aux environs de 38° (tuberculose, hyperthyroïdie) (page 26), pas dans la septicémie.

Question 3 : À propos des types de fièvre, quelle affirmation est exacte ?

(2026)

- A. La fièvre ondulante présente des pics fébriles quotidiens atteignant 40 °C le soir avec rémission matinale à 37 °C, comme dans la péritonite.
- B. La fièvre intermittente de type quarte correspond à des accès fébriles tous les deux jours, typiques du paludisme à Plasmodium falciparum.
- C. La fièvre en plateau montre une variation thermique de plus de 2 °C en 24 h, comme observé dans la septicémie.
- D. La fièvre rémittente quotidienne se caractérise par une température matinale subnormale suivie d'une élévation vespérale à 39–40 °C, observée dans les suppurations profondes.
- E. La fébricule correspond à une température persistante à 39,5 °C, typique des lymphomes.

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — La fièvre ondulante ne présente pas des pics quotidiens à 40°C avec rémission matinale à 37°C. Elle se caractérise par des poussées thermiques à début et fin progressives alternant avec des rémissions complètes (page 25). La description correspond plutôt à la fièvre rémittente.
- **B : Faux** — La fièvre intermittente de type quarte correspond à des accès fébriles tous les 3 jours (J1, J4, J7...) et non tous les deux jours. De plus, elle est typique du paludisme à Plasmodium malariae, pas à P. falciparum (page 22).
- **C : Faux** — La fièvre en plateau montre une faible rémission de 0,5°C le matin, pas une variation de plus de 2°C (page 20).
- **D : Vrai** — La fièvre rémittente quotidienne : température matinale sub-normale, élévation vespérale à 39-40°C, observée dans les suppurations profondes et la péritonite (page 21).
- **E : Faux** — La fébricule correspond à un décalage thermique aux environs de 38°C (page 26), pas à 39,5°C.

Question 4 : Quel élément constitue un critère absolu de gravité justifiant une hospitalisation urgente chez un patient fébrile ?

(2026)

- A. Température à 38,8 °C avec céphalées modérées.
- B. Fièvre à 39,5 °C avec frissons chez un patient diabétique.
- C. Purpura cutané associé à une fièvre supérieure à 40 °C.
- D. Fièvre depuis 5 jours sans réponse aux antipyrétiques.
- E. Asthénie marquée avec amaigrissement de 2 kg en un mois.

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Température à 38,8°C avec céphalées modérées ne constitue pas un critère de gravité absolu.
- **B : Faux** — Fièvre à 39,5°C avec frissons chez un patient diabétique est un facteur de risque mais pas un critère absolu de gravité.
- **C : Vrai** — Un purpura cutané associé à une fièvre supérieure à 40°C est un signe de gravité majeur (purpura fébrile = urgence thérapeutique), évoquant notamment une infection invasive à méningocoque ou une autre septicémie grave.
- **D : Faux** — Fièvre depuis 5 jours sans réponse aux antipyrétiques justifie une exploration mais n'est pas un critère absolu d'hospitalisation urgente.
- **E : Faux** — Asthénie marquée avec amaigrissement de 2 kg en un mois est un signe d'alerte mais pas un critère absolu de gravité immédiate.

3- Sémiologie pondérale et trouble de l'hydratation**Question 5 : Le (les) signe (s) cliniques de déshydratation Intracellulaire :**

(Dr Kahel,2024,ratt2024)

- A. Soif intense.
- B. Polypnée, fièvre.
- C. Troubles de la conscience.
- D. Sécheresse des muqueuses.
- E. Toutes les réponses sont justes.

RÉPONSE : E**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — La soif intense est un signe de déshydratation intracellulaire.
- **B : Vrai** — La polypnée et la fièvre sont des signes de déshydratation intracellulaire.
- **C : Vrai** — Les troubles de la conscience sont des signes de déshydratation intracellulaire.
- **D : Vrai** — La sécheresse des muqueuses est un signe de déshydratation intracellulaire.

Question 6 : Concernant l'obésité: une réponse juste

(Dr Kahel,2024)

- A. L'obésité androïde: prédominante à la partie inférieure du corps et à la paroi abdominale.
- B. Obésité gynoïde: intéressant surtout la ceinture pelvienne (bassin,hanches) et le ventre.
- C. Obésité cushingoïde: qui est une obésité facio-tronculaire.
- D. Obésité mixte; secondaire à une hypersécrétion du cortisol.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — L'obésité androïde est prédominante à la partie supérieure du corps (thorax, abdomen) et non à la partie inférieure.
- **B : Faux** — L'obésité gynoïde intéresse surtout la ceinture pelvienne (bassin, hanches) et les cuisses, pas le ventre.
- **C : Vrai** — L'obésité cushingoïde est une obésité facio-tronculaire (visage, cou, tronc) avec respect des membres.
- **D : Faux** — L'obésité mixte n'est pas secondaire à une hypersécrétion du cortisol. C'est l'obésité cushingoïde qui est liée à l'hypercortisolisme.

Question 7 : Monsieur H M consulte pour œdèmes des membres inférieurs qui sont blancs, mous, indolores, prenant le godet, symétriques et déclives. Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic (s) que vous évoquez:

(Dr Kahel,2024,2025)

1. Cirrhose hépatique (stade de décompensation oedemto-ascitique).
2. Insuffisance cardiaque droite.
3. Insuffisance cardiaque globale.
4. Syndrome néphrotique.
5. Thrombose veineuse profonde des membres inférieurs.

- A. 1.4
- B. 3.5
- C. 2
- D. 1.5
- E. 1.2.3.4.5

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- **1 : Vrai** — La cirrhose hépatique au stade de décompensation œdémato-ascitique donne des œdèmes des membres inférieurs bilatéraux, blancs, mous, indolores, prenant le godet, symétriques et déclives (liés à l'hypertension portale et à l'hypoalbuminémie).
- **2 : Faux** — L'insuffisance cardiaque droite donne des œdèmes des membres inférieurs, mais ils sont généralement associés à d'autres signes (turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, hépatomégalie).
- **3 : Faux** — L'insuffisance cardiaque globale peut donner des œdèmes, mais la réponse A ne l'inclut pas.
- **4 : Vrai** — Le syndrome néphrotique donne des œdèmes blancs, mous, indolores, prenant le godet, symétriques et déclives.
- **5 : Faux** — La thrombose veineuse profonde donne un œdème unilatéral, chaud, douloureux, ne prenant pas le godet de manière aussi caractéristique.

Question 8 : Cause d'amaigrissements avec anorexie : RJ

(Dr Kahel,ratt2024)

- A. Diabète sucré type 1
- B. Cancer
- C. Hyperthyroïdie
- D. Diarrhées chroniques
- E. Parasitose intestinale (ténia)

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Le diabète sucré type 1 donne un amaigrissement avec polyphagie (augmentation de l'appétit), pas anorexie.
- **B : Vrai** — Le cancer est une cause classique d'amaigrissement avec anorexie.
- **C : Faux** — L'hyperthyroïdie donne un amaigrissement avec polyphagie (appétit conservé ou augmenté).
- **D : Faux** — Les diarrhées chroniques donnent un amaigrissement mais l'appétit est généralement conservé.
- **E : Faux** — La parasitose intestinale (ténia) donne un amaigrissement avec appétit conservé ou augmenté.

Question 9 : La déshydratation extracellulaire se reconnaît sur les signes suivants RF

(Dr Kahel,2025)

- A. La peau perd son élasticité normale
- B. Hypotonie des globes oculaire
- C. Hypotension artérielle et bradycardie
- D. Oligurie.
- E. Perte de poids,

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — La peau perd son élasticité normale (signe du pli cutané).
- **B : Vrai** — L'hypotonie des globes oculaires est un signe de déshydratation extracellulaire.
- **C : Faux** — Si la déshydratation extracellulaire entraîne bien une hypotension artérielle (par hypovolémie), l'organisme réagit de manière compensatrice en augmentant la fréquence cardiaque. On observe donc une tachycardie et non une bradycardie.
- **D : Vrai** — L'oligurie est un signe de déshydratation extracellulaire.
- **E : Vrai** — La perte de poids est un signe de déshydratation extracellulaire.

Question 10 : L'obésité RF

(Dr Kahel,2025)

- A. Est un excès de poids en rapport avec l'augmentation de la masse active.
- B. Un sujet obèse est un sujet qui présente un excès de poids sup à 20 % par rapport au poids normal
- C. un sujet obèse est un sujet qui présente un BMI supérieur à 30kg/m2
- D. Il est inclut de ce cadre les excès hydriques
- E. Elle présente un facteur de risque cardio vasculaire

RÉPONSE : A / D**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — L'obésité est un excès de masse grasse, pas de masse active (masse maigre).
- **B : Vrai** — Un sujet obèse présente un excès de poids supérieur à 20% par rapport au poids normal.
- **C : Vrai** — Un sujet obèse présente un BMI (IMC) supérieur à 30 kg/m².
- **D : Faux** — L'obésité n'inclut pas les excès hydriques (oedèmes).
- **E : Vrai** — Elle constitue un facteur de risque cardio-vasculaire majeur.

Question 11 : Parmi les éléments suivants, lequel ne correspond pas à une caractéristique qualitative du comportement alimentaire chez un patient obèse ?

(2026)

- A. Des crises d'ingestion massive d'aliments variés, survenant en dehors de tout sentiment de faim, et révélatrices d'une décompensation psychique grave.
- B. Une consommation excessive due à une élévation du seuil de satiété, entraînant une ingestion alimentaire quantitative important
- C. Une impulsion soudaine et irréversible à consommer un aliment particulier, généralement riche en glucides.
- D. Ingestion quasi continue de petites quantités d'aliments tout au long de la journée, sans véritable repas structuré.
- E. La présence de compulsions alimentaires liées à des émotions intenses ou au stress psychologique .

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — Les crises d'ingestion massive (binge eating) sont une caractéristique qualitative.
- **B : Faux** — Une consommation excessive due à une élévation du seuil de satiété est une caractéristique quantitative, pas qualitative.
- **C : Vrai** — L'impulsion soudaine à consommer un aliment particulier (craving) est une caractéristique qualitative.
- **D : Vrai** — L'ingestion quasi continue de petites quantités (grignotage) est une caractéristique qualitative.
- **E : Vrai** — Les compulsions alimentaires liées aux émotions sont une caractéristique qualitative.

Question 12 : Parmi les complications mécaniques de l'obésité, laquelle est la plus fréquemment associée aux troubles de la statique vertébrale ?

(2026)

- A. Scoliose idiopathique
- B. Arthrose des hanches et des genoux
- C. Spondylarthrite ankylosante
- D. Fracture vertébrale ostéoporotique
- E. Toutes les réponses sont justes

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — La scoliose idiopathique n'est pas directement liée à l'obésité.
- **B : Vrai** — L'arthrose des hanches et des genoux est une complication mécanique fréquente de l'obésité retentissant sur la statique lombo-pelvienne.
- **C : Faux** — La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire, pas une complication mécanique de l'obésité.
- **D : Faux** — La fracture vertébrale ostéoporotique n'est pas une complication mécanique directe de l'obésité.

Question 13 : Quelle affirmation est exacte concernant l'anasarque ?

(2026)

- A. C'est un œdème localisé aux paupières et au dos des mains
- B. Elle se manifeste uniquement par un œdème sous-cutané généralisé
- C. Elle associe d'un œdème sous-cutané généralisé à des épanchements séreux (ascite, hydrothorax)
- D. Elle est signe typique des œdèmes récents
- E. Elle est signe exclusif d'insuffisance cardiaque

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — L'anasarque n'est pas un œdème localisé aux paupières et au dos des mains.
- **B : Faux** — L'anasarque ne se manifeste pas uniquement par un œdème sous-cutané généralisé.
- **C : Vrai** — L'anasarque associe un œdème sous-cutané généralisé à des épanchements séreux (ascite, hydrothorax).
- **D : Faux** — L'anasarque n'est pas un signe typique des œdèmes récents.
- **E : Faux** — L'anasarque n'est pas un signe exclusif d'insuffisance cardiaque.

Question 14 : Chez un patient présentant un œdème des membres inférieurs bilatéral, associé à une circulation veineuse collatérale abdominale, un ictère et des angiomes stellaires, quelle est la cause la plus probable ?

(2026)

- A. Insuffisance cardiaque droite
- B. Syndrome néphrotique
- C. Maladie hépatique chronique
- D. Entéropathie exsudative
- E. Hypothyroïdie sévère

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — L'insuffisance cardiaque droite donne des œdèmes mais pas d'ictère ni d'angiomes stellaires.
- **B : Faux** — Le syndrome néphrotique donne des œdèmes mais pas de circulation collatérale abdominale, ni ictère, ni angiomes stellaires.
- **C : Vrai** — La maladie hépatique chronique (cirrhose) associe œdèmes des membres inférieurs, circulation veineuse collatérale abdominale, ictère et angiomes stellaires.
- **D : Faux** — L'entéropathie exsudative donne des œdèmes mais pas les autres signes.
- **E : Faux** — L'hypothyroïdie sévère donne des œdèmes (myxoœdème) mais pas les autres signes.

Question 15 : En cas de déshydratation extracellulaire d'origine digestive, quelle est la caractéristique attendue de la natriurèse ?

(2026)

- A. Supérieure à 3 g/l
- B. Comprise entre 1 et 2 g/l
- C. Supérieure à 2 g/l
- D. Inférieure à 500 mg/l
- E. Variable, sans valeur diagnostique

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Une natriurèse supérieure à 3 g/l n'est pas attendue dans la déshydratation extracellulaire d'origine digestive.
- **B : Faux** — Une natriurèse comprise entre 1 et 2 g/l n'est pas caractéristique.
- **C : Faux** — Une natriurèse supérieure à 2 g/l n'est pas attendue.
- **D : Vrai** — En cas de déshydratation extracellulaire d'origine digestive, il y a une hypovolémie efficace qui entraîne une rétention hydrosodée rénale, donc une natriurèse basse, inférieure à 500 mg/l (ou < 20 mmol/l).
- **E : Faux** — La natriurèse a une valeur diagnostique dans ce contexte.

4- Signes fonctionnels cardiaques

Question 16 : La douleur de la péricardite est:

(2024,ratt2024,2025)

- A. Retrosternate diffuse Irradiant à la mâchoire
- B. Rétro sternale localisée, sans irradiation
- C. Persistante dans le temps
- D. Soulagée par la position couchée
- E. Toutes les réponses sont fausses

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La douleur de la péricardite n'irradie pas à la mâchoire (c'est l'angor qui irradie à la mâchoire et aux membres supérieurs).
- **B : Vrai** — La douleur de la péricardite est rétro sternale, localisée, sans irradiation caractéristique.
- **C : Faux** — La douleur de la péricardite n'est pas persistante dans le temps de manière continue. Elle est augmentée par l'inspiration et soulagée par la position penchée en avant.
- **D : Faux** — La douleur de la péricardite est soulagée par la position penchée en avant, pas par la position couchée (qui l'aggrave souvent).

Question 17 : Monsieur C. 55 ans, consulte pour une dyspnée d'effort gênante à la marche normale et plat. Dans quelle classe fonctionnelle (classification internationale NYHA) peut-on situer ce patient

(ratt2024)

- A. Classe 0
- B. Classe 1
- C. Classe 2
- D. Classe 3
- E. Classe 4

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La classe 0 n'existe pas.
- **B : Faux** — La classe 1 : dyspnée pour des efforts importants (escaliers, côtes).
- **C : Faux** — La classe 2 : dyspnée pour des efforts modérés (marche normale en terrain plat, mais peut monter un étage sans s'arrêter).
- **D : Vrai** — La classe 3 : dyspnée pour des efforts minimes (marche normale en terrain plat, le patient doit s'arrêter pour reprendre son souffle). La description "dyspnée d'effort gênante à la marche normale et plat" correspond à la classe 3.
- **E : Faux** — La classe 4 : dyspnée au repos.

Question 18 : Une douleur thoracique rétro sternale diffuse, persistante plus de 5 minutes même après la prise de trinitrine et irradiant à la mâchoire et aux membres supérieurs, vous fait évoquer:

(2025)

- A. Une péricardite
- B. Un pneumothorax
- C. Un syndrome coronarien aigu
- D. Une dissection de l'aorte
- E. Toutes les réponses sont justes

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La péricardite donne une douleur augmentée par l'inspiration, soulagée par la position penchée en avant, sans irradiation à la mâchoire.
- **B : Faux** — Le pneumothorax donne une douleur en coup de poignard, latéro-thoracique, avec dyspnée.
- **C : Vrai** — Une douleur rétro sternale diffuse, persistante > 5 min, résistante à la trinitrine, irradiant à la mâchoire et aux membres supérieurs est typique d'un syndrome coronarien aigu (SCA).
- **D : Faux** — La dissection aortique donne une douleur intense d'emblée maximale, migratrice, irradiant dans le dos.

Question 19 : Les malformations du thorax :

(2026)

- A. Thorax en bréchet signifie une augmentation du diamètre antéro-postérieur
- B. Thorax en tonneau signifie une saillie en avant du sternum
- C. Thorax en entonnoir signifie un enfoncement anormal du sternum
- D. Une cyphose signifie une asymétrie thoracique par distension d'un hémithorax
- E. Toutes ces réponses sont fausses

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Le thorax en bréchet (pectus carinatum) signifie une saillie en avant du sternum, pas une augmentation du diamètre antéro-postérieur.
- **B : Faux** — Le thorax en tonneau signifie une augmentation du diamètre antéro-postérieur (horizontalisation des côtes), pas une saillie en avant du sternum.
- **C : Vrai** — Le thorax en entonnoir (pectus excavatum) signifie un enfoncement anormal du sternum.
- **D : Faux** — La cyphose signifie une déformation de la colonne vertébrale en arrière, pas une asymétrie thoracique par distension d'un hémithorax.

Question 20 : L'infarctus du myocarde se différencie et l'angor d'effort par:

(2026)

- A. Une Douleur brève survenant au repos
- B. Une Douleur prolongée (> 20 min), non soulagée par le repos
- C. Une Douleur calmée par la nitroglycérine
- D. Une Douleur de type pleural
- E. Une Douleur thoracique irradiant vers le dos

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — La douleur de l'infarctus est prolongée, pas brève.
- **B : Vrai** — La douleur de l'infarctus est prolongée (> 20 min), non soulagée par le repos, contrairement à l'angor qui est brève et calmée par le repos.
- **C : Faux** — La douleur de l'infarctus n'est pas calmée par la nitroglycérine, contrairement à l'angor.
- **D : Faux** — La douleur de l'infarctus n'est pas de type pleural.
- **E : Faux** — L'irradiation vers le dos n'est pas spécifique.

Question 21 : Quelle est l'irradiation typique de la douleur dans la dissection aortique?

(2026)

- A. Vers les membres supérieurs uniquement
- B. Vers la mâchoire et le bras gauche
- C. Dans le dos, descendant vers les lombes ou l'abdomen
- D. Vers le cou et la région occipitale
- E. Localisée uniquement au thorax antérieur

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — L'irradiation vers les membres supérieurs uniquement n'est pas typique.
- **B : Faux** — L'irradiation vers la mâchoire et le bras gauche est typique de l'infarctus.
- **C : Vrai** — La douleur de la dissection aortique est médiane, rétrosternale, et irradie dans le dos, descendant vers les lombes ou l'abdomen.
- **D : Faux** — L'irradiation vers le cou et la région occipitale n'est pas typique.
- **E : Faux** — La douleur n'est pas localisée uniquement au thorax antérieur.

Question 22 : Un patient de 45 ans présente une douleur thoracique rétrosternale, d'apparition spontanée, vive, augmentée par l'inspiration et la toux, et soulagée par l'antéflexion du tronc. L'auscultation cardiaque révèle un frottement péricardique râpeux mésocardiaque, persistant en apnée et renforcé par la pression du stéthoscope. Quel est le diagnostic le plus probable ?

(2026)

- A. Infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST
- B. Angine de poitrine instable
- C. Péricardite aiguë virale
- D. Embolie pulmonaire
- E. Tamponnade

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — L'infarctus donne une douleur constrictive, non augmentée par l'inspiration, sans frottement péricardique.
- **B : Faux** — L'angine de poitrine instable donne une douleur constrictive à l'effort, sans frottement.
- **C : Vrai** — La péricardite aiguë virale associe : douleur rétrosternale vive, augmentée par l'inspiration et la toux, soulagée par l'antéflexion du tronc, et un frottement péricardique râpeux.
- **D : Faux** — L'embolie pulmonaire donne une douleur basithoracique, pas de frottement péricardique.
- **E : Faux** — La tamponnade donne une hypotension, une turgescence jugulaire, un pouls paradoxal, pas de frottement péricardique typique.

5- Signes physiques cardiaques

Question 23 : Quel est l'élément sémiologique qui permet d'affirmer l'origine cardiaque d'une....

(ratt2024)

- A. Œdème des membres inférieurs
- B. Ascite
- C. Reflux hépatojugulaire
- D. Asthénie
- E. Circulation collatérale.

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — L'œdème des membres inférieurs peut avoir une origine cardiaque, rénale, hépatique ou veineuse. Il n'est pas spécifique de l'origine cardiaque.
- **B : Faux** — L'ascite peut avoir une origine cardiaque (insuffisance cardiaque droite), hépatique (cirrhose) ou néphrotique. Elle n'est pas spécifique.
- **C : Vrai** — Le reflux hépatojugulaire est un signe clinique qui traduit une insuffisance cardiaque droite. Il est très évocateur d'une origine cardiaque (page 26).
- **D : Faux** — L'asthénie est un signe non spécifique.
- **E : Faux** — La circulation collatérale peut avoir une origine cardiaque (syndrome cave supérieur) ou hépatique (hypertension portale). Elle n'est pas spécifique.

Question 24 : Dans quelle condition le B1 est-il assourdi?

(2025)

- A. Insuffisance mitrale (IM)
- B. Rétrécissement aortique (RA)
- C. Hypertension pulmonaire (HTAP)
- D. Emphysème

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Dans l'insuffisance mitrale, le B1 est assourdi car la valve mitrale ne se ferme pas complètement (défaut de coaptation).
- **B : Faux** — Dans le rétrécissement aortique, le B1 est généralement normal.
- **C : Faux** — Dans l'HTAP, on peut avoir un éclat du B2 (composante pulmonaire), pas un assourdissement du B1.
- **D : Faux** — Dans l'emphysème, les bruits cardiaques sont assourdis de manière globale, mais pas spécifiquement le B1.

Question 25 : Qu'est-ce que le B3 représente dans le cycle cardiaque ?

(2025)

- A. La phase de contraction ventriculaire
- B. La phase initiale rapide de remplissage ventriculaire
- C. La phase de relaxation des oreillettes
- D. La phase de remplissage auriculaire

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — La contraction ventriculaire correspond à la systole.
- **B : Vrai** — Le B3 correspond à la phase de remplissage ventriculaire rapide (protodiastolique). Il est physiologique chez le sujet jeune, pathologique après 40 ans (insuffisance cardiaque).
- **C : Faux** — La relaxation des oreillettes n'est pas le B3.
- **D : Faux** — La phase de remplissage auriculaire (télédiastolique) correspond au B4.

Question 26 : Quelle est l'irradiation typique du souffle d'insuffisance aortique ?

(2025)

- A. Vers l'épaule droite
- B. Le long du bord gauche du sternum et vers la pointe
- C. Vers les vaisseaux du cou
- D. Vers l'arcade costale gauche

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — L'irradiation vers l'épaule droite n'est pas typique de l'IA.
- **B : Vrai** — Le souffle d'insuffisance aortique (souffle diastolique) s'irradie classiquement le long du bord gauche du sternum et vers la pointe (foyer aortique accessoire : Erb).
- **C : Faux** — L'irradiation vers les vaisseaux du cou est typique du rétrécissement aortique (souffle systolique).
- **D : Faux** — L'irradiation vers l'arcade costale gauche n'est pas typique.

Question 27 : Le rythme de Duroziez :

(2026)

- A. Un Claquement d'ouverture de la mitrale
- B. Un roulement systolique
- C. Un éclat de B2 à la pointe
- D. Un souffle systolique au foyer mitral
- E. Toutes ces réponses sont justes

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — Le rythme de Duroziez caractérise l'auscultation du rétrécissement mitral (RM) à la pointe du cœur. Ce rythme classique associe précisément un éclat du premier bruit (B1) (et non de B2), un claquement d'ouverture de la mitrale (COM), un roulement diastolique (et non systolique), et un renforcement pré-systolique. La seule proposition exacte listée ici est donc l'existence d'un claquement d'ouverture de la mitrale.
- **B : Faux** — Le roulement est diastolique et non systolique.
- **C : Faux** — Il y a un éclat du B1 à l'apex et non du B2.
- **D : Faux** — Il n'y a pas de souffle systolique mitral typique dans le RM pur.
- **E : Faux** — Toutes les réponses ne sont pas justes.

Question 28 : Un souffle cardiaque fonctionnel se distingue d'un souffle organique par :

(2026)

- A. L'absence de symptômes cardiaques associés
- B. Une intensité variable avec l'état physique
- C. L'absence d'anomalie organique à l'échocardiographie
- D. Toutes ces réponses sont justes
- E. Toutes ces réponses sont fausses

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — Absence totale de retentissement fonctionnel et de symptômes cardiovasculaires.
- **B : Vrai** — Intensité faible (grade 1 à 2/6), très variable selon l'effort, la fièvre ou la position.
- **C : Vrai** — Échocardiographie strictement normale sans valvulopathie anatomique.
- **D : Vrai** — L'ensemble de ces propositions caractérise avec certitude le souffle innocent fonctionnel.

6- Péricardite

Question 29 : Quels sont les signes fonctionnels qui peuvent accompagner une péricardite aiguë (RF):

(2024,ratt2024)

- A. Fièvre
- B. Dyspnée
- C. Œdème des membres inférieurs
- D. Dysphagie
- E. Hoquet

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — La fièvre est contemporaine de la douleur.
- **B : Vrai** — La dyspnée modérée, calmée par la position penchée en avant, fait partie des signes fonctionnels.
- **C : Faux** — L'œdème des membres inférieurs n'est pas un signe fonctionnel de la péricardite aiguë. Il se voit dans la péricardite constrictive (syndrome de Pick) ou l'insuffisance cardiaque droite.
- **D : Vrai** — La dysphagie peut accompagner une péricardite aiguë par compression œsophagienne postérieure.
- **E : Vrai** — Le hoquet peut accompagner une péricardite aiguë par irritation du nerf phrénique.

Question 30 : La tamponnade:

(2024,ratt2024,2025)

- A. Est une constitution d'un tampon au niveau de la valves sigmoïdes
- B. Est constitution rapide d'un épanchement péricardique entraînant un tableau d'adiastolie aiguë.
- C. Est, la formation d'un thrombus au niveau de l'oreillette droite entraînant une embolie pulmonaire
- D. Est l'existence d'une acidose métabolique compensée par un tampon basique
- E. Est le battement du cœur contre la paroi thoracique

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La tamponnade n'est pas la constitution d'un tampon au niveau des valves sigmoïdes.
- **B : Vrai** — La tamponnade est la constitution rapide d'un épanchement péricardique compressif entraînant un tableau d'adiastolie aiguë avec effondrement du débit cardiaque.
- **C : Faux** — La tamponnade n'est pas la formation d'un thrombus intracardiaque.
- **D : Faux** — La tamponnade n'est pas une acidose métabolique compensée.
- **E : Faux** — Ce n'est pas le choc contre la paroi thoracique.

Question 31 : La radiographie thoracique au cours de la péricardite aiguë: RF

(2024,ratt2024)

- A. N'est significatif que dans les péricardites avec épanchement
- B. Observe une augmentation du volume cardiaque
- C. Montre une cardiomégalie en sabot
- D. Montre une cardiomégalie en carafe en cas d'épanchement
- E. Peut être normale

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — L'examen radiologique n'est significatif que dans les péricardites avec épanchement abondant (> 250 ml).
- **B : Vrai** — On observe un élargissement de l'index cardiothoracique.
- **C : Faux** — La cardiomégalie en sabot est typique des cardiopathies congénitales (tétralogie de Fallot), pas de la péricardite.
- **D : Vrai** — Aspect triangulaire symétrique ou silhouette en carafe / calebasse.
- **E : Vrai** — La radiographie peut être strictement normale en cas de péricardite sèche ou de faible abondance.

Question 32 : Parmi les signes suivants lequel n'appartient pas au tableau clinique de Péricardite constrictive

(2026)

- A. Turgescence spontanée des jugulaires
- B. Hépatomégalie congestive
- C. Œdèmes des membres inférieurs
- D. Ascite
- E. Hypotension artérielle sévère avec pouls paradoxal > 10 mmHg

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — La turgescence spontanée des jugulaires fait partie du syndrome de Pick.
- **B : Vrai** — L'hépatomégalie congestive fait partie du syndrome de Pick.
- **C : Vrai** — Les œdèmes des membres inférieurs font partie du syndrome de Pick.
- **D : Vrai** — L'ascite précoce et récidivante fait partie du syndrome de Pick.
- **E : Faux** — L'hypotension artérielle sévère avec pouls paradoxal > 10 mmHg est le signe d'urgence de la tamponnade aiguë, pas de la péricardite constrictive chronique.

7- Valvulopathies

Question 33 : Le SS du rétrécissement aortique: Cochez la réponse fausse.

(2024,ratt2024,2025)

- A. Il siège au foyer aortique.
- B. irradie aux vaisseaux du cou.
- C. Il est Souvent intense s'accompagnant d'un frémissement.
- D. Il est de timbre rude et râpeux, tonalité grave.
- E. C'est un souffle de régurgitation.

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le souffle systolique du RAO siège au 2e espace intercostal droit (foyer aortique).
- **B : Vrai** — Il irradie typiquement le long des carotides aux vaisseaux du cou.
- **C : Vrai** — Il est souvent intense ($\geq 4/6$) s'accompagnant d'un frémissement au foyer aortique.
- **D : Vrai** — Timbre rude, râpeux, en jet de vapeur éjectionnel.
- **E : Faux** — Le souffle du RAO est un souffle d'éjection mésosystolique (losangique), pas un souffle de régurgitation (qui est celui de l'IM ou de l'IT).

Question 34 : Vous examinez un malade avec RM serré pur : Cochez la réponse fausse :

(2024,ratt2024,2025)

- A. Notion d'hospitalisation pour des épisodes d'OAP.
- B. Frémissement cataire diastolique à l'apex.
- C. Déviation en bas et en dehors du choc de pointe.
- D. Triade de Duroziez au foyer mitral, décubitus latéral gauche.
- E. La radio retrouve un arc inférieur droit en double contour (dilatation de l'OG).

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Notion d'hospitalisation pour des épisodes récurrents d'OAP cardiogénique.
- **B : Vrai** — Frémissement cataire diastolique palpatoire à l'apex.
- **C : Faux** — La déviation en bas et en dehors du choc de pointe traduit une dilatation ou hypertrophie du VG. Or dans le RM pur, le VG est protégé et de volume normal ou diminué.
- **D : Vrai** — Triade/rythme de Duroziez au foyer mitral recherché en décubitus latéral gauche.
- **E : Vrai** — Double contour de l'arc inférieur droit attestant de la dilatation majeure de l'oreillette gauche.

Question 35 : Dans l'IM chronique importante. Cochez la réponse fausse.

(ratt2024,2025)

- A. Il y a une dyspnée d'effort qui s'aggrave progressivement.
- B. Auscultation d'un souffle d'IM en jet de vapeur.
- C. La surcharge volumétrique du VG entraîne une dilatation du VG.
- D. Auscultation d'un souffle d'IM à la pointe, irradiant vers les carotides.
- E. La radio montre un arc inférieur gauche allongé (dilatation VG).

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Dyspnée d'effort qui s'aggrave progressivement avec l'évolution de la fuite.
- **B : Vrai** — Souffle holosystolique classique de timbre doux en jet de vapeur.
- **C : Vrai** — La surcharge volumétrique diastolique chronique conduit à une dilatation ventriculaire gauche excentrique.
- **D : Faux** — Le souffle d'IM irradie vers l'aisselle gauche, jamais vers les carotides (ce qui est l'apanage du rétrécissement aortique).
- **E : Vrai** — L'arc inférieur gauche est allongé et saillant à la radiographie par dilatation du VG.

Question 36 : Dans la pathologie aortique. Cochez la réponse fausse.

(ratt2024)

- A. L'angor, la syncope d'effort et la dyspnée d'effort sont les trois maîtres symptômes du rétrécissement aortique.
- B. Souffle mésosystolique, éjectionnel, intense, rude, râpeux est en faveur du rétrécissement aortique.
- C. Signes périphériques du rétrécissement aortique serré : Elargissement de PA différentielle + Hyperpulsatilité artérielle.
- D. L'insuffisance aortique aiguë peut donner un tableau d'OAP cardiogénique.
- E. Souffle d'insuffisance aortique est protodiastolique, doux, humé, aspiratif, d'embée maximal il évolue decrescendo

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — L'angor, la syncope d'effort et la dyspnée d'effort forment la triade clinique historique du RAO serré.
- **B : Vrai** — Souffle mésosystolique rude, éjectionnel, râpeux caractéristique du RAO.
- **C : Faux** — L'élargissement de la PA différentielle et l'hyperpulsatilité artérielle (pouls de Corrigan) sont les signes cardinaux de l'insuffisance aortique, non du rétrécissement aortique (qui pince la différentielle).
- **D : Vrai** — L'insuffisance aortique aiguë provoque une montée foudroyante des pressions gauches et un OAP cardiogénique.
- **E : Vrai** — Souffle protodiastolique doux, humé, aspiratif decrescendo maximal le long du bord gauche du sternum.

8- Insuffisance cardiaque

Question 37 : Une hépatomégalie au cours de l'insuffisance cardiaque droite est:

(2024)

- A. Lisse, ferme à la palpation,
- B. Douleuruse à la palpation
- C. S'accompagnant d'un reflux hépato-jugulaire
- D. Toutes ces réponses sont justes
- E. Toutes les réponses sont fausses

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — L'hépatomégalie de l'insuffisance cardiaque droite est régulière, lisse et ferme (foie cardiaque).
- **B : Vrai** — Elle est douloureuse spontanément ou à la palpation (hépatalgie d'effort / foie accordéon).
- **C : Vrai** — Elle s'accompagne d'un reflux hépato-jugulaire franc, signe majeur de surcharge cavitaire droite.
- **D : Vrai** — Toutes ces caractéristiques sont systématiquement observées dans l'IC droite congestive.

Question 38 : Dans l'insuffisance cardiaque gauche. Cochez la réponse fausse.

(ratt2024,2025)

- A. L'Insuffisance Cardiaque Gauche s'accompagne d'une augmentation de la pression dans le VG, dans L'OG et les capillaires pulmonaires.
- B. L'insuffisance mitrale est une étiologie de l'insuffisance cardiaque gauche.
- C. Les signes fonctionnels sont des signes essentiellement pulmonaires.
- D. La dyspnée croît progressivement et en l'absence de traitement.
- E. La PAS est très élevée avec un élargissement de la différentielle.

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Augmentation rétrograde de la pression télédiastolique du VG, de l'OG et de la pression capillaire pulmonaire.
- **B : Vrai** — L'insuffisance mitrale est une étiologie fréquente de défaillance cardiaque gauche.
- **C : Vrai** — Signes d'amont pulmonaires prédominants : dyspnée, orthopnée, dyspnée paroxystique nocturne.
- **D : Vrai** — La dyspnée progresse spontanément selon la classification NYHA.
- **E : Faux** — Dans l'IC gauche évoluée, le débit cardiaque s'effondre avec hypotension ou pincement différentiel. L'élargissement différentiel n'est pas un signe d'insuffisance cardiaque gauche mais d'insuffisance aortique.

9- ECG

Question	réponse
Il n'y a pas de QCS à ce cours dans les examens disponibles	

10- HTA

Question 39 : L'hypertension artérielle. Cochez la réponse fausse.

(ratt2024,2025)

- A. L'hypertension artérielle (HTA) est l'élévation transitoire des chiffres de la pression artérielle (PAS > 140 mmHg et/ou PAD > 90 mmHg).
- B. L'urgence hypertensive est un pic hypertensif isolé (TA > 180-110mmHg).
- C. L'HTA blouse blanche: Si la tension est élevée au cabinet du médecin et normal dans la MAPA.
- D. La consommation excessive d'alcool est une cause toxique d'HTA.
- E. Fond d'œil est un bilan du retentissement ophtalmologique d'HTA.

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — L'HTA est l'élévation permanente (et non transitoire) des chiffres tensionnels (PAS $\geq$ 140 mmHg et/ou PAD $\geq$ 90 mmHg), mesurée au repos et confirmée lors de plusieurs consultations.
- **B : Vrai** — L'urgence hypertensive et la crise aiguë hypertensive se caractérisent par des chiffres sévères > 180/110 mmHg.
- **C : Vrai** — L'HTA blouse blanche associe chiffres élevés au cabinet et normaux en ambulatoire (MAPA ou automesures).
- **D : Vrai** — La consommation excessive d'alcool est une cause toxique reconnue d'HTA secondaire ou d'aggravation.
- **E : Vrai** — Le fond d'œil permet d'apprécier la microangiopathie et la sévérité du retentissement rétinien.

Question 40 : Chez un patient hypertendu sous traitement, présentant une atteinte des organes cibles (HVG), mais dont les auto-mesures à domicile montrent des valeurs normales, quelle est l'indication principale de la (MAPA) ?

(2026)

- A. Évaluer la variabilité nocturne de la PA pour rechercher un profil non-dipper.
- B. Confirmer l'existence d'une HTA masquée.
- C. Diagnostiquer une hypotension orthostatique symptomatique.
- D. Exclure une HTA de blouse blanche.
- E. Vérifier l'efficacité d'un traitement enregistré via télétransmission.

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — L'évaluation du profil nocturne non-dipper est informative mais découle de l'exploration globale.
- **B : Vrai** — La discordance entre automesures normales et présence formelle d'atteinte d'organe cible (HVG) est l'indication reine pour démasquer une HTA masquée ou une hypertension nocturne isolée via la MAPA.
- **C : Faux** — L'hypotension orthostatique se recherche par manœuvre active de lever avec brassard.
- **D : Faux** — La blouse blanche produit des chiffres élevés au cabinet et normaux au domicile, ce qui ne concorde pas avec un retentissement viscéral persistant sous traitement.
- **E : Faux** — La télétransmission n'est pas la finalité médicale de l'indication.

Question 41 : Chez un patient de 27 ans, hypertendu à 170/105 mm Hg sous double thérapie bien suivie, sans antécédents familiaux d'HTA, non obèse, sans consommation de sel excessive, quelle est l'attitude la plus appropriée ?

2026

- A. Poursuivre la même prise en charge, car il s'agit probablement d'une HTA essentielle précoce.
- B. Rechercher systématiquement une apnée du sommeil avant toute autre exploration.
- C. Considérer l'existence d'une HTA résistante et initier une trithérapie.
- D. Ne pas suspecter d'HTA secondaire car la pression artérielle n'atteint pas 180/110 mm Hg.
- E. Explorer une possible étiologie secondaire en raison de l'âge jeune et de la mauvaise réponse au traitement.

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **: Faux** —
- **: Faux** —
- **: Faux** —
- **: Faux** —
- **: Faux** —

11- Risque cardio vasculaire

Question 42 : Les facteurs de risque cardiovasculaire: Cochez la réponse fausse.

2024,ratt2024,2025

- A. L'âge et le sexe sont des FDR cardiovasculaires non modifiables.
- B. La sédentarité est un FDR cardiovasculaire modifiable.
- C. infarctus du myocarde ou mort subite après l'âge de 55 ans chez le père est un FDR cardiovasculaire.
- D. L'hypertriglycéridémie augmente le risque de développer une maladie cardiovasculaire
- E. Le syndrome métabolique est un important FDR CV prédispose à la survenue d'événements cardiovasculaires

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 43 : Quel antécédent familial définit un facteur de risque cardiovasculaire non modifiable selon les critères de risque précoce ?

2026

- A. Mère décédée d'un infarctus du myocarde à 68 ans.
- B. Père décédé d'une mort subite à 52 ans.
- C. Oncle paternel décédé d'un AVC à 54 ans.
- D. Grand-mère maternelle décédée d'un IDM à 70 ans.
- E. Frère aîné diabétique de type 2, décédé d'un infarctus à 59 ans.

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 44 : Sont considérés comme facteurs de risque cardiovasculaire : (cocher la réponse fausse)

2026

- A. Le tabagisme actif
- B. L'hypertension artérielle
- C. Le diabète
- D. L'hyperthyroïdie
- E. La dyslipidémie

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

12- SCA

Question 45 : Le syndrome coronarien aigu. Cochez la réponse fausse.

2025

- A. La douleur est moins sensible voire résistant à la trinitrine.
- B. STEMI est une occlusion complète.
- C. Aspect normal de l'ECG n'écarte pas le NSTEMI.
- D. STEMI est toujours associé à une élévation des troponines
- E. L'angor instable est un SCA avec absence d'élévation des troponines

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 47 : Le syndrome coronarien aigu (SCA) : (cocher la réponse fausse)

2026

- A. Est dû à un déséquilibre entre les apports et les besoins en O₂ au niveau du myocarde.
- B. La douleur est rétrosternale constrictive avec irradiation vers la mâchoire et aux membres supérieurs.
- C. La douleur thoracique apparaît à l'effort et cède au repos et à la prise de trinitrine
- D. La douleur thoracique apparaît au repos et est résistante à la prise de trinitrine
- E. Le traitement repose essentiellement sur la reperfusion myocardique

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 48 : Dans le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST (ST+) : (cocher la réponse juste)

2026

- A. Le diagnostic repose essentiellement sur la présentation clinique et l'aspect électrique (ECG)
- B. Le diagnostic repose essentiellement sur le dosage des troponines
- C. La clinique est caractérisée par une douleur thoracique qui augmente à l'inspiration profonde et qui est soulagée par la position penchée en avant.
- D. Il touche principalement les sujets jeunes sans facteurs de risque cardiovasculaire
- E. Le traitement repose essentiellement sur la prise des anti-inflammatoires

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

13- Douleur thoracique**Question 49 : La douleur thoracique. Cochez la réponse fausse.**

2024,2025

- A. La douleur de l'angor d'effort est rétro sternale localisée irradiant au niveau du bras gauche.
- B. L'angor crescendo c'est l'angor aggravé avec une diminution rapide du niveau des efforts déclenchant les crises d'angor.
- C. L'angor d'effort correspond en général à la constitution d'un caillot intra-luminal intra coronaire.
- D. Le STEMI est un SCA avec une élévation des troponines.
- E. Le NSTEMI est un SCA avec une élévation des troponines.

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 50 : Parmi les situations cliniques suivantes laquelle correspond à l'angor de novo ?

2026

- A. Crises apparaissent uniquement lors d'efforts très intenses
- B. Diminution rapide du seuil d'effort déclenchant les crises
- C. Premières crises d'angor d'emblée sévères
- D. Crises survenant exclusivement la nuit
- E. Angor associé à une élévation significative de la troponine

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 51 : Parmi les causes des douleurs thoraciques laquelle ne relève PAS d'une urgence vitale immédiate ? (RF)

2026

- A. Reflux gastro-œsophagien
- B. Infarctus du myocarde
- C. Dissection aortique
- D. Embolie pulmonaire grave
- E. Tamponnade

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

14- Sémiologie vasculaire

Question 52 : Que peut indiquer un affaiblissement ou une disparition des pouls fémoraux avec conservation ou augmentation des pouls radiaux ?

2025

- A. Coarctation de l'aorte
- B. Artérite périphérique
- C. Insuffisance cardiaque
- D. Thrombose totale d'une artère iliaque

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 53 : Quelle caractéristique du membre inférieur peut être observée dans le cas de la TVP ?

2025

- A. Membre inférieur gonflé, rouge et chaud
- B. Membre inférieur pâle et froid
- C. Membre inférieur dur et immobile
- D. Membre inférieur avec des signes de décoloration bleutée

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 54 : Quel phénomène décrit le pouls paradoxal de Kussmaul ?

2025

- A. Une variation de l'amplitude du pouls en fonction des mouvements respiratoires, observée dans l'épanchement péricardique de grande abondance ou la péricardite constrictive
- B. Une diminution du pouls durant l'inspiration
- C. Un pouls trop rapide pendant l'expiration
- D. Un pouls très lent, irrégulier

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —

Question 55 : Quelle est la complication majeure de la thrombose veineuse des membres inférieurs :

2026

- A. OAP
- B. Embolie pulmonaire
- C. Paralyse du membre inférieur
- D. Ischémie du membre inférieur
- E. Risque d'amputation du membre inférieur

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

15- Signes fonctionnels respiratoires

Question 56 : La bradypnée inspiratoire peut se voir :

Dr Ouchene,ratt2024

- A. Au cours d'une crise d'asthme
- B. Au cours d'une laryngite
- C. En cas d'acidose métabolique
- D. Dans les syndromes restrictifs
- E. Toutes ces réponses sont justes

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 57 : La douleur d'origine pleurale est :

Dr Ouchene,ratt2024

- A. habituellement étendue.
- B. à type d'oppression thoracique
- C. soulagée par la toux
- D. déclenchée par l'inspiration profonde
- E. toutes ces réponses sont justes

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 58 : Une toux productive matinale fait évoquer :

Dr Ouchene,ratt2024

- A. un asthme bronchique
- B. un cancer bronchique
- C. une dilatation des bronches
- D. une allergie
- E. toutes ces réponses sont justes

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 59 : Une dyspnée aiguë inspiratoire : (RE)

Dr Ouchene, 2025

- A. Est souvent d'origine laryngée
- B. L'asthme en est la cause la plus fréquente
- C. Peut être d'origine trachéale
- D. Peut s'accompagner d'un sifflement
- E. Peut s'accompagner d'une modification de la voix.

RÉPONSE : A, C, D, E**JUSTIFICATION :**

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 60 : Une douleur hémi-thoracique en coup de poignard fait évoquer en premier : (RJ)

Dr Ouchene, 2025

- A. Une origine pleurale
- B. Un syndrome coronarien
- C. Une pneumopathie
- D. Toutes ces réponses sont justes
- E. Toutes ces réponses sont fausses

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- : Faux —
- : Faux —

Question 61 : L'hémoptysie : (RJ)

Dr Ouchene, 2025

- A. Le rejet par la bouche du sang noirâtre
- B. Le rejet par le nez de sang rouge dans un effort d'éternuement
- C. Le rejet par la bouche de sang rouge vif dans un effort de toux
- D. Le rejet par la bouche de sang rouge vif aéré dans un effort de vomissement
- E. Toutes ces réponses sont fausses

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 62 : L'hémoptysie est :

2026

- A. Le rejet par le nez de sang rouge lors d'un effort de toux
- B. Le rejet de sang rouge par la bouche lors d'un effort de vomissement
- C. Le rejet par la bouche de sang noirâtre lors d'un effort de toux
- D. Le rejet par la bouche de sang rouge lors d'un effort de toux
- E. Le rejet brusque par la bouche d'une grande quantité de pus

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- : Faux —
- : Faux —

Question 63 : Un patient de 55 ans consulte pour une douleur du membre supérieur gauche, accentuée sur la face interne. Quels diagnostics faut-il évoquer ? (RF)

2026

- A. Atteinte du sommet pulmonaire homolatéral
- B. Atteinte vertébrale cervico-thoracique
- C. Une pathologie articulaire de l'épaule droite
- D. Atteinte cardiaque
- E. Atteinte du plexus brachial

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 64 : Une abolition du murmure vésiculaire se voit au cours de :

Dr Ouchene, ratt2024

- A. Epanchement pleural liquidien
- B. Epanchement pleural aérien
- C. Un syndrome de condensation pulmonaire
- D. Toutes ces réponses sont justes
- E. A et B sont justes

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

16- Signes physiques respiratoires

Question 65 : Le ou les signes extra-thoraciques pouvant orienter vers une insuffisance respiratoire chronique :

Dr Ouchene, 2025

- A. Un hippocratisme digital
- B. Des angiomes stellaires
- C. Une gynécomastie
- D. Un œdème en pèlerine
- E. Toutes ces réponses sont justes

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —

Question 66 : Le syndrome de Claude Bernard-Horner associe classiquement :

2026

- A. Une énophtalmie
- B. Une déviation de la commissure labiale
- C. Un myosis
- D. A et C sont justes
- E. A, B et C sont justes

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

17- Syndrome pulmonaire

Question 68 : Les signes de condensation pulmonaire : (RF)

2025

- A. Palpation : augmentation des vibrations vocales.
- B. Percussion : matité.
- C. Auscultation : exagération du murmure vésiculaire
- D. Abolition du murmure vésiculaire
- E. Peut être retrouvés en cas de PFLA

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

18- Syndrome pleuraux

Question 69 : Au cours de l'épanchement pleural liquidien de moyenne abondance, on retrouve : (RE)

2025

- A. Abolition des vibrations vocales à la palpation
- B. Matité franche de bois à la palpation
- C. La limite supérieure décrit la courbe de Damoiseau à percussion.
- D. Abolition du murmure vésiculaire à l'auscultation
- E. Douleur basithoracique avec dyspnée

RÉPONSE : **A, C, D, E**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 70 : Le trépied de Gaillard associe :

2025

- A. Abolition des vibrations vocales (palpation).
- B. Exagération des vibrations vocales (palpation)
- C. Tympanisme (percussion).
- D. Abolition du murmure vésiculaire (auscultation).
- E. Matité (auscultation)
- F. A, C, D
- G. A, B, C
- H. A, D, E
- I. A, C, D, E

RÉPONSE : **a**

JUSTIFICATION :

- : Faux —

Question 71 : Au cours de la pleurésie, la toux :

2026

- A. Est sèche, secondaire à une irritation bronchique
- B. Est productive, liée à une irritation pleurale
- C. Est secondaire à la compression alvéolaire par la plèvre
- D. Aucune réponse n'est juste

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 72 : Un liquide pleural exsudatif :

Dr Ouchene,ratt2024

- A. Est un liquide riche en protéine
- B. Est un liquide pauvre en lymphocytes
- C. Peut être d'origine cardiaque
- D. Peut être d'origine hépatique
- E. Toutes ces réponses sont justes

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 73 : L'IDR à la tuberculine :

Dr Ouchene,ratt2024

- A. Est basée sur l'injection sous cutanée de tuberculine
- B. Sa positivité permet de retenir le diagnostic de tuberculose
- C. Sa négativité permet d'éliminer le diagnostic de tuberculose
- D. Toutes ces réponses sont fausses
- E. Toutes ces réponses sont justes

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 74 : La bronchoscopie permet (RF) :

2026

- A. D'examiner l'appareil bronchique
- B. De réaliser des lavages broncho-alvéolaires
- C. De pratiquer des biopsies endobronchiques
- D. De pratiquer des biopsies pleurales
- E. De pratiquer des biopsies transbronchiques

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 75 : Quel est l'apport principal de l'exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) dans l'asthme ?

2026

- A. Mise en évidence d'un trouble ventilatoire restrictif
- B. Mise en évidence d'un trouble obstructif réversible
- C. Mesure exclusive de la capacité de diffusion
- D. Détection d'un syndrome ventilatoire mixte obligatoire
- E. Confirmation d'un emphysème pulmonaire

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 76 : Le syndrome cave supérieur associe :

ratt2024

- A. Cyanose de la face
- B. Œdème en pèlerine avec comblement des creux sus-claviculaires
- C. Céphalées
- D. Turgescence des veines jugulaires
- E. Toutes les réponses sont justes

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- : Faux —

Question 77 : Toutes ces pathologies peuvent être responsables d'un syndrome médiastinal de la loge antéro-supérieure, sauf une, laquelle ?

ratt2024

- A. Adénopathies
- B. Goitre
- C. Anévrisme aortique
- D. Hernie hiatale
- E. Tumeur thymique

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —

Question 78 : Un patient présente une triade : dyspnée, sifflement, dysphonie, avec à l'examen clinique une paralysie de la corde vocale gauche. L'exploration retrouve une masse thoracique. Pour que cette masse explique ces symptômes elle doit être localisée à quel niveau du médiastin ?

2026

- A. Syndrome médiastinal antérieur
- B. Syndrome médiastinal moyen
- C. Syndrome médiastinal postérieur
- D. Syndrome médiastinal inférieur
- E. Aucune réponse n'est juste

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

Question 79 : Laquelle des propositions suivantes correspond le mieux à l'atteinte du plexus brachial (C8–D1) dans le syndrome de Pancoast-Tobias ?

2026

- A. Douleur irradiant sur la face externe du bras et le pouce
- B. Troubles sensitifs prédominants au niveau du 1er et 2e doigt
- C. Douleur descendant sur le bord interne du bras jusqu'au 5e doigt
- D. Contexte évocateur d'une fracture de la clavicule
- E. Déficit moteur prédominant du muscle deltoïde

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —
- : Faux —

21- Syndrome bronchique

Question 80 : Devant un asthme bronchique : (RF)

ratt2024

- A. La disparition des râles sibilants est nécessaire, pour arrêter le traitement de la crise
- B. Les Explorations Fonctionnelles Respiratoire (EFR) permettent le diagnostic et la surveillance
- C. On retrouve une amélioration des EFR après utilisation des bronchodilatateurs
- D. Le téléthorax peut montrer un élargissement des espaces intercostaux avec horizontalisation des côtes

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- : Faux —
- : Faux —

II- Physiopathologie:

1- Physiopathologie de la maladie thromboembolique

Question 1 : Conséquences hémodynamiques au cours de l'embolie pulmonaire :

(Dr Gallez, 2025)

- A. Une diminution de la pression artérielle pulmonaire (PAP)
- B. Augmentation de la contractilité du VD.
- C. Augmentation de la précharge du VG.
- D. Un bas débit cardiaque, hypotension artérielle et état de choc.

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — L'embolie pulmonaire entraîne une augmentation de la pression artérielle pulmonaire (PAP) par obstruction mécanique.
- **B : Faux** — L'augmentation de la postcharge du VD peut entraîner une dilatation et une défaillance du VD, pas une augmentation de la contractilité.
- **C : Faux** — L'embolie pulmonaire entraîne une diminution de la précharge du VG (obstruction au retour veineux pulmonaire).
- **D : Vrai** — L'embolie pulmonaire grave peut entraîner un bas débit cardiaque, une hypotension artérielle et un état de choc (choc obstructif).

Question 2 : Effet espace mort initial au cours de l'embolie pulmonaire correspond :

(Dr Gallez, 2025)

- A. Territoires non ventilés non perfusés
- B. Territoires non ventilés mais perfusés
- C. Territoires ventilés mais non perfusés
- D. Territoires bien ventilés et perfusés

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Territoires non ventilés non perfusés : pas d'échange.
- **B : Faux** — Territoires non ventilés mais perfusés : effet shunt.
- **C : Vrai** — L'embolie pulmonaire entraîne une obstruction de l'artère pulmonaire, créant des territoires ventilés mais non perfusés (effet espace mort, $VA/Q > 1$).
- **D : Faux** — Territoires bien ventilés et perfusés : échange normal ($VA/Q = 1$).

2- Physiopathologie de la thermorégulation

Question 3 : Les réponses de l'organisme à la chaleur (RF) :

(ratt2024)

- A. Vasodilatation des vaisseaux sous-cutanés visant à augmenter le volume sanguin refroidi en périphérie
- B. Sudation, réduisant la T° par évaporation de la sueur
- C. Frisson
- D. Tachypnée ou polypnée, augmentant les pertes de chaleur par l'air expiré
- E. Diminution de l'activité métabolique

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Vasodilatation des vaisseaux sous-cutanés visant à augmenter le volume sanguin refroidi en périphérie.
- **B : Vrai** — Sudation, réduisant la température par évaporation de la sueur.
- **C : Faux** — Le frisson est une réponse au froid (thermogenèse), pas à la chaleur.
- **D : Vrai** — Tachypnée ou polypnée, augmentant les pertes de chaleur par l'air expiré (évaporation pulmonaire).
- **E : Vrai** — Diminution de l'activité métabolique (pour réduire la production de chaleur).

Question 4 : Le centre de la thermogenèse est :

(Dr Gallez, 2025)

- A. Le bulbe rachidien
- B. Hypothalamus antérieur
- C. Hypothalamus postérieur
- D. Le cervelet

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Le bulbe rachidien n'est pas le centre de la thermogenèse.
- **B : Faux** — L'hypothalamus antérieur est le centre de la thermolyse (réponse à la chaleur).
- **C : Vrai** — L'hypothalamus postérieur est le centre de la thermogenèse (réponse au froid).
- **D : Faux** — Le cervelet n'est pas le centre de la thermogenèse.

Question 5 : Le centre de la thermolyse est :

(Dr Gallez, 2025, 2026)

- A. Le bulbe rachidien
- B. Hypothalamus antérieur
- C. Hypothalamus postérieur
- D. Le cervelet

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Le bulbe rachidien n'est pas le centre de la thermolyse.
- **B : Vrai** — L'hypothalamus antérieur est le centre de la thermolyse (réponse à la chaleur, vasodilatation).
- **C : Faux** — L'hypothalamus postérieur est le centre de la thermogenèse.
- **D : Faux** — Le cervelet n'est pas le centre de la thermolyse.

Question 6 : Effet de la fièvre sur l'organisme :

(Dr Gallez, 2025)

- A. Ralentit la fréquence cardiaque
- B. Épisodes de sommeil à ondes lentes plus nombreux
- C. Ralentit la cicatrisation
- D. Accélère la croissance bactérienne

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — La fièvre accélère la fréquence cardiaque (8-12 battements/min pour chaque 1°C).
- **B : Vrai** — La fièvre augmente les épisodes de sommeil à ondes lentes (ont une action réparatrice sur le cerveau).
- **C : Faux** — La fièvre accélère la cicatrisation et la réponse immunitaire.
- **D : Faux** — La fièvre inhibe la croissance bactérienne.

Question 7 : La contraction musculaire dans l'hyperthermie maligne est due à :

(2026)

- A. Libération excessive de calcium
- B. Libération excessive de magnésium
- C. Libération excessive de succinylcholine
- D. Libération excessive de potassium

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — L'hyperthermie maligne est due à un dysfonctionnement d'un canal libérant le calcium au niveau du réticulum sarcoplasmique, provoquant une libération excessive de calcium et des contractions généralisées non coordonnées.
- **B : Faux** — Le magnésium n'est pas impliqué dans ce mécanisme direct.
- **C : Faux** — La succinylcholine est un déclencheur (relaxant musculaire), pas la cause directe intracellulaire de la contraction.
- **D : Faux** — Le potassium n'est pas la cause directe de la contraction musculaire.

3- Physiopathologie des troubles hydro-sodés

Question 8 : Cochez la réponse juste :

(Dr Bengana, 2025, 2026)

- A. L'osmolarité est la somme des concentrations de toutes les molécules diffusibles ou non diffusibles, dissoutes dans un litre de plasma.
- B. L'osmolarité plasmatique = $([Na^+] + [K^+]) \times 2$
- C. L'osmolarité est la somme des concentrations de toutes les molécules non diffusibles dissoutes dans un litre de plasma
- D. À l'état physiologique l'osmolarité intracellulaire est inférieure à l'osmolarité extracellulaire
- E. L'osmolarité normale = 258 mOsm/l

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — L'osmolarité est la somme des concentrations de toutes les molécules diffusibles ou non diffusibles, dissoutes dans un litre de plasma.
- **B : Faux** — L'osmolarité plasmatique = $([Na^+] + [K^+]) \times 2 + Gly + Urée$. La formule présentée est incomplète.
- **C : Faux** — L'osmolarité inclut toutes les molécules. La définition restreinte correspond à la tonicité ou osmolalité efficace.
- **D : Faux** — À l'état physiologique, l'osmolarité intracellulaire est égale à l'osmolarité extracellulaire (équilibre osmotique).
- **E : Faux** — L'osmolalité normale est de 285-295 mOsm/kg d'eau, pas 258 mOsm/l.

Question 9 : Cochez la réponse fausse :

(Dr Bengana, 2025, 2026)

- A. Le Sodium (Na^+) est le principal cation extracellulaire.
- B. La différence de concentration des ions de part et d'autre de la membrane cellulaire est responsable de la pression osmotique.
- C. Les transferts de l'eau à l'intérieur de l'organisme sont passifs, suivant les différences de pressions et de concentration.
- D. La pression hydrostatique et la pression oncotique sont responsables des échanges hydriques dans le milieu extracellulaire.
- E. La pression osmotique est responsable des échanges hydriques dans le milieu extracellulaire.

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le sodium (Na^+) est le principal cation extracellulaire.
- **B : Vrai** — La différence de concentration des ions de part et d'autre de la membrane cellulaire est responsable de la pression osmotique.
- **C : Vrai** — Les transferts de l'eau à l'intérieur de l'organisme sont passifs, suivant les différences de pressions et de concentration.
- **D : Vrai** — La pression hydrostatique et la pression oncotique régissent les échanges transcapillaires dans le milieu extracellulaire (Starling).
- **E : Faux** — La pression osmotique est responsable des échanges entre le milieu intracellulaire et extracellulaire (transmembranaires), et non uniquement au sein du milieu extracellulaire.

Question 10 : Cochez la réponse fausse :

(Dr Bengana, 2025)

- A. Les troubles d'hydratation extracellulaire purs sont dus à une perte ou un excès hydrosodé isotonique de l'organisme.
- B. Dans l'hyperhydratation intracellulaire, le facteur déclenchant est un excès en eau = bilan hydrique positif.
- C. L'hypo-osmolalité plasmatique entraîne un mouvement d'eau vers les cellules (hyperhydratation intracellulaire).
- D. L'hypo-osmolalité plasmatique entraîne un mouvement d'eau vers le milieu extracellulaire (hyperhydratation extracellulaire).
- E. Dans la déshydratation extracellulaire, le facteur déclenchant est une perte de sel (diminution du capital sodé).

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Les troubles d'hydratation extracellulaire purs sont dus à une variation hydrosodée isotonique.
- **B : Vrai** — L'hyperhydratation intracellulaire résulte d'un excès d'eau (bilan hydrique positif).
- **C : Vrai** — L'hypo-osmolalité plasmatique crée un gradient osmotique attirant l'eau vers les cellules.
- **D : Faux** — L'hypo-osmolalité plasmatique attire l'eau vers l'intérieur des cellules (milieu intracellulaire), et non vers le milieu extracellulaire.
- **E : Vrai** — La déshydratation extracellulaire est consécutive à une perte hydrosodée avec prédominance sodée (diminution du capital sodé).

4- Physiopathologie de la dénutrition

Question 11 : Cochez la réponse fausse :

(Dr Bengana, 2025, 2026)

- A. La dénutrition est associée à des états de malnutrition par excès (surpoids et obésité).
- B. Les carences spécifiques ne font pas partie de la dénutrition.
- C. La dénutrition est perçue comme une malnutrition par défaut d'apport, amenant le plus souvent à un amaigrissement.
- D. Le terme de « sous-nutrition » (undernutrition) pourrait être plus informatif que le terme de « dénutrition ».
- E. Le déséquilibre nutritionnel est caractérisé par un bilan énergétique et/ou protéique négatif.

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La dénutrition doit être strictement dissociée des états de malnutrition par excès (surpoids, obésité). Elle ne leur est pas associée.
- **B : Vrai** — Les carences spécifiques (en vitamines ou micronutriments) ne constituent pas la dénutrition globale.
- **C : Vrai** — La dénutrition est une malnutrition par défaut d'apport conduisant à un amaigrissement.
- **D : Vrai** — Le terme de sous-nutrition est parfois jugé plus précis.
- **E : Vrai** — Il existe un bilan énergétique et/ou protéique négatif.

Question 12 : Cochez la réponse juste :

(Dr Bengana, 2025, 2026)

- A. Les nutriments dits énergétiques (ou caloriques) sont : les protéines, les lipides, les glucides et les vitamines
- B. Au cours de la période post-absorptive, les substrats absorbés sont distribués et stockés dans l'organisme.
- C. Au cours de la période post-absorptive, on observe une diminution du taux d'insuline.
- D. Au cours de la période de jeûne de courte durée, la cétogenèse occupe une place majeure pour permettre l'économie azotée.
- E. Au cours de la dénutrition par augmentation des dépenses énergétiques, la cétogenèse joue un rôle important pour permettre l'économie azotée.

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Les vitamines ne sont pas des nutriments énergétiques.
- **B : Vrai** — Durant la période post-absorptive, les substrats sont distribués et mis en réserve.
- **C : Faux** — La période post-absorptive s'accompagne d'un pic d'insuline (anabolisme), pas d'une diminution.
- **D : Faux** — La cétogenèse majeure intervient lors du jeûne prolongé, pas de courte durée.
- **E : Faux** — En cas d'hypercatabolisme inflammatoire, la cétogenèse protectrice est altérée.

Question 13 : La dénutrition par augmentation des dépenses énergétiques (forme hypercatabolique) (RF) :

(Dr Bengana, 2025)

- A. Associe une carence d'apport et un stress métabolique lié à l'agression
- B. Est caractérisée par une perte protéique, une perte de masse et de fonction musculaires
- C. C'est une dénutrition à prédominance protéique.
- D. Biologiquement, on peut trouver un syndrome inflammatoire et/ou une albumine diminuée.
- E. C'est une forme dont l'évolution est plutôt chronique et sans œdème.

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Associe déficit d'apports et stress agression.
- **B : Vrai** — Marquée par une fonte musculaire rapide.
- **C : Vrai** — Dénutrition à prédominance protéique (kwashiorkor-like).
- **D : Vrai** — Syndrome inflammatoire biologique fréquent avec hypoalbuminémie.
- **E : Faux** — C'est une forme d'évolution aiguë ou subaiguë, souvent associée à des œdèmes. Le marasme est chronique et sans œdème.

5- Physiopathologie des troubles de l'hématose

Question 14 : A quel mécanisme physiopathologique correspond le trouble de l'hématose secondaire à un pneumothorax ?

(ratt2024)

- A. Atteinte de la fonction pompe ventilatoire
- B. Atteinte de la fonction de transport
- C. Atteinte de la fonction d'échange pulmonaire
- D. Trouble de la diffusion
- E. Toutes les propositions sont justes

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le pneumothorax entraîne un collapsus pulmonaire et une altération de la mécanique ventilatoire (atteinte de la fonction pompe).
- **B : Faux** — Concerne l'anémie ou le CO.
- **C : Faux** — Concerne la membrane alvéolo-capillaire.
- **D : Faux** — Trouble de la diffusion interstitielle.

6- Physiopathologie de l'insuffisance respiratoire

Question 15 : Je suis une atteinte de la fonction d'échange pulmonaire, principalement la conséquence d'une altération du rapport entre la ventilation alvéolaire et la perfusion pulmonaire, où des zones normalement ventilées ne sont pas ou peu perfusées. Le rapport VA/Q est supérieur à 1. Qui suis-je ?

(ratt2024)

- A. Effet shunt
- B. Shunt vrai
- C. Effet espace mort
- D. Trouble de la diffusion
- E. Hypoxémie d'altitude

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Effet shunt = $VA/Q < 1$.
- **B : Faux** — Shunt vrai = $VA/Q = 0$.
- **C : Vrai** — L'effet espace mort correspond à des zones ventilées mais non ou mal perfusées ($VA/Q > 1$).
- **D, E : Faux.**

Question 16 : L'effet shunt correspond à :

(Dr Rahmi, 2025)

- A. Territoires non ventilés non perfusés
- B. Territoires non ventilés mais perfusés
- C. Territoires ventilés mais non perfusés
- D. Territoires bien ventilés et perfusés

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Pas d'échange.
- **B : Vrai** — L'effet shunt correspond à des territoires non ventilés mais perfusés ($VA/Q < 1$, tendant vers 0).
- **C : Faux** — Effet espace mort.
- **D : Faux** — Zone normale.

Question 17 : Conséquences hémodynamiques au cours de l'embolie pulmonaire :

(2026)

- A. Une diminution de la pression artérielle pulmonaire (PAP)
- B. Augmentation de la contractilité du VD
- C. Augmentation de la précharge du VG
- D. Un bas débit cardiaque, hypotension artérielle et état de choc

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Augmentation de la PAP.
- **B : Faux** — Postcharge augmentée, pas la contractilité intrinsèque.
- **C : Faux** — Diminution de la précharge VG.
- **D : Vrai** — Bas débit, hypotension et choc obstructif.

Question 18 : L'effet espace mort au cours de l'embolie pulmonaire correspond à :

(2026)

- A. Territoires non ventilés non perfusés
- B. Territoires non ventilés mais perfusés
- C. Territoires ventilés mais non perfusés
- D. Territoires bien ventilés et perfusés

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D : Faux.**
- **C : Vrai** — Territoires ventilés mais non perfusés (espace mort alvéolaire).

Question 19 : Parmi les signes d'une insuffisance respiratoire aiguë :

(2026)

- A. Polyglobulie
- B. Polypnée superficielle avec tirage
- C. Hippocratisme digital
- D. Baisse de la libido
- E. Cœur pulmonaire chronique

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A, C, E : Faux** — Signes d'insuffisance respiratoire chronique.
- **B : Vrai** — La polypnée avec tirage est un signe de détresse respiratoire aiguë.
- **D : Faux.**

Question 20 : Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) est sévère lorsque :

(2026)

- A. $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \geq 300$ mmHg
- B. $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \geq 200$ mmHg
- C. $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 100$ mmHg
- D. $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$ mmHg
- E. $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300$ mmHg

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, E : Faux** — Pas de SDRA ou SDRA léger.
- **C : Vrai** — $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 100$ mmHg définit un SDRA sévère selon Berlin.
- **D : Faux** — SDRA modéré.

7- Physiopathologie de l'état de choc (cardiogénique, septique, anaphylactique).

Question 21 : Les médiateurs néoformés, au cours de la réaction anaphylactique sont : (RF)

(ratt2024)

- A. Le thromboxane A₂
- B. Les prostacyclines
- C. La tryptase
- D. Le platelet activating factor (PAF)
- E. Les leucotriènes

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Médiateur néoformé (acide arachidonique).
- **B : Vrai** — Médiateur néoformé.
- **C : Faux** — La tryptase est un médiateur préformé stocké dans les granules mastocytaires. C'est la réponse fausse recherchée.
- **D : Vrai** — Médiateur néoformé.
- **E : Vrai** — Médiateurs néoformés.

Question 22 : L'hypersensibilité de type 1 : (RJ)

(ratt2024)

- A. C'est une hypersensibilité immédiate
- B. Survient en quelques minutes à quelques heures
- C. Évolue en 2 phases : sensibilisation puis activation
- D. La symptomatologie clinique est secondaire à une histaminolibération
- E. Toutes les réponses sont justes

RÉPONSE : E**JUSTIFICATION :**

- **A, B, C, D : Vrais** — Toutes ces caractéristiques décrivent l'hypersensibilité immédiate de type 1.
- **E : Vrai** — Toutes les propositions sont justes.

Question 23 : Le choc anaphylactique peut relever d'une :

(2025)

- A. Réaction d'hypersensibilité de type 1
- B. Réaction d'hypersensibilité de type 2
- C. Réaction d'hypersensibilité de type 3
- D. Réaction d'hypersensibilité de type 4
- E. Toutes ces réponses sont justes

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — Le choc anaphylactique est une réaction d'hypersensibilité immédiate de type 1.
- **B, C, D : Faux.**

Question 24 : L'état de choc cardiogénique peut être la conséquence de :

(2025)

- A. Une augmentation du volume télédiastolique
- B. Une augmentation du volume d'éjection systolique
- C. Une baisse du volume télésystolique
- D. Une augmentation du débit cardiaque
- E. Toutes les réponses sont justes

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — La défaillance myocardique entraîne une augmentation du volume télédiastolique (dilatation).
- **B, C, D : Faux** — Le VES et le débit cardiaque sont abaissés, et le volume télésystolique est augmenté.

Question 25 : Quelle est la conséquence commune à tous les états de choc ?

(2026)

- A. Hypervolémie
- B. Hyperperfusion tissulaire
- C. Hypoperfusion tissulaire
- D. Hypotension artérielle
- E. Hyperthermie

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A, B, D, E : Faux.**
- **C : Vrai** — La caractéristique physiopathologique commune à tous les états de choc est l'hypoperfusion tissulaire généralisée.

8- Physiopathologie de l'HTA

Question 26 : La régulation à moyen terme de la pression artérielle : (RF)

(Dr Rahmi, 2025, ratt2024)

- A. Fait appel à la régulation hormonale
- B. Se fait par le système rénine-angiotensine-aldostérone
- C. Fait appel aux peptides natriurétiques (ANP et BNP)
- D. Fait appel à l'hormone antidiurétique (ADH)
- E. Se fait par le phénomène dit de natriurèse de pression

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Régulation hormonale impliquée.
- **B : Vrai** — SRAA acteur majeur du moyen terme.
- **C : Vrai** — Peptides natriurétiques impliqués.
- **D : Vrai** — ADH impliquée dans le contrôle hydrique.
- **E : Faux** — La natriurèse de pression est le mécanisme fondamental de la régulation à long terme de la pression artérielle. C'est la réponse fausse recherchée.

Question 27 : Si la TA chute brutalement, quelle est la première réaction du corps ?

(2026)

- A. Tachycardie réflexe
- B. Vasoconstriction
- C. Vasodilatation
- D. A + B
- E. A + C

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- Lors d'une chute brutale de la pression artérielle, les barorécepteurs sont stimulés et déclenchent une réponse immédiate du système nerveux sympathique :
- **A : Vrai** — Tachycardie réflexe (augmentation de la fréquence cardiaque).
- **B : Vrai** — Vasoconstriction périphérique (augmentation des résistances vasculaires).
- **C : Faux** — La vasodilatation diminuerait encore la pression artérielle.
- **D : Vrai** — A + B sont les premières réactions.
- **E : Faux** — A + C est incorrect car la vasodilatation n'est pas une réponse adaptative à l'hypotension.
- **Conclusion** : La première réaction du corps à une chute brutale de la TA est une tachycardie réflexe associée à une vasoconstriction (réponse sympathique).

9- Physiopathologie de l'état de choc hypovolémique

Question 28 : Le choc hypovolémique se traduit par : (RJ)

(Dr Rahmi, 2025, ratt2024, 2026)

- A. Un retour veineux augmente et un débit cardiaque diminue
- B. Un retour veineux diminue et un débit cardiaque diminue
- C. Un retour veineux diminue et un débit cardiaque augmente
- D. Un retour veineux augmente et un débit cardiaque augmente +
- E. Aucune réponse juste

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Le retour veineux diminue (pas augmente) dans le choc hypovolémique.
- **B : Vrai** — La diminution du volume intravasculaire induit une diminution du retour veineux, ce qui engendre une diminution du débit cardiaque (page 21).
- **C : Faux** — Le débit cardiaque diminue (pas augmente).
- **D : Faux** — Le retour veineux et le débit cardiaque diminuent tous les deux.

Question 29 : L'hypoperfusion tissulaire d'un choc peut être responsable des signes suivants : (RF)

(Dr Rahmi, 2025, ratt2024)

- A. Oligurie
- B. Crises convulsives
- C. Marbrures cutanées
- D. Hyperlactatémie
- E. Hypoxémie

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Oligurie (hypoperfusion rénale).
- **B : Vrai** — Crises convulsives (hypoperfusion cérébrale).
- **C : Vrai** — Marbrures cutanées (hypoperfusion cutanée).
- **D : Vrai** — Hyperlactatémie (métabolisme anaérobie).
- **E : Faux** — L'hypoxémie n'est pas une conséquence directe de l'hypoperfusion tissulaire. L'hypoxémie est une diminution de la PaO₂, liée à un trouble de l'hématose (pulmonaire), pas directement à l'hypoperfusion tissulaire. L'hypoperfusion entraîne une hypoxie tissulaire (défaut d'apport d'O₂ aux tissus), mais pas une hypoxémie (baisse de la PaO₂). Ce sont deux notions différentes.

Question 30 : Les conséquences pulmonaires de l'état de choc hypovolémique : (RF)

(2026)

- A. Hypoxémie
- B. Hypoventilation
- C. Augmentation du travail respiratoire
- D. Épuisement
- E. S. D. R. A

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — L'hypoxémie est une conséquence pulmonaire
- **B : Faux** — L'hypoventilation n'est pas une conséquence typique. On observe plutôt une hyperventilation.
- **C : Vrai** — L'augmentation du travail respiratoire
- **D : Vrai** — L'épuisement
- **E : Vrai** — Le SDRA (Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë)

Question 31 : Un des signes de l'état de choc hypovolémique : (RJ)

(2026)

- A. TA systolique < 90 mmHg et moyenne < 65 mmHg
- B. Pouls rapide, filant
- C. Hyper lactatémie > 4 mmol/l
- D. Oligurie
- E. Aucune réponse juste

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — TA systolique < 90 mmHg et moyenne < 65 mmHg est un signe de choc, mais la question demande "un des signes" et la formulation peut être restrictive.
- **B : Faux** — Pouls rapide, filant est un signe de choc.
- **C : Faux** — Hyperlactatémie > 4 mmol/l est un signe de choc.
- **D : Faux** — Oligurie est un signe de choc.
- **E : Vrai** — Aucune réponse juste ? Non, toutes ces réponses sont des signes de choc hypovolémique. La question demande "un des signes" et toutes les propositions A, B, C, D sont des signes. Donc E est fausse.

10- Physiopathologie des œdèmes pulmonaires

Question 32 : œdème pulmonaire : (RF)

(Dr Rahmi, 2025, ratt2024)

- A. Entraîne précocement une baisse de la compliance
- B. Entraîne un effet shunt responsable d'une hypoxémie.
- C. Est un déterminant de l'hypertension artérielle pulmonaire, par l'hypoxémie mais aussi par la compression vasculaire pulmonaire qu'il entraîne.
- D. Peut résulter d'une augmentation de la pression capillaire pulmonaire (OAP Cardiogénique)
- E. Peut résulter d'une rupture complète de la barrière alvéolocapillaire (OAP Hémodynamique)

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — L'œdème pulmonaire entraîne précocement une baisse de la compliance pulmonaire (le poumon devient rigide, difficile à distendre).
- **B : Vrai** — L'œdème pulmonaire entraîne un effet shunt (zones non ventilées mais perfusées) responsable d'une hypoxémie.
- **C : Vrai** — L'œdème pulmonaire est un déterminant de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), par l'hypoxémie (vasoconstriction hypoxique) et par la compression vasculaire pulmonaire.
- **D : Vrai** — L'œdème pulmonaire peut résulter d'une augmentation de la pression capillaire pulmonaire (OAP cardiogénique).
- **E : Faux** — L'œdème pulmonaire peut résulter d'une rupture complète de la barrière alvéolo-capillaire, mais cela correspond à un OAP lésionnel (SDRA), pas à un OAP hémodynamique. L'OAP hémodynamique (cardiogénique) est dû à une augmentation de la pression hydrostatique, sans rupture complète de la barrière. La proposition E associe "rupture complète" à "OAP hémodynamique", ce qui est faux.

11- Physiopathologie de l'insuffisance cardiaque

Question	réponse
Il n'y a pas de QCSs à ce cours dans les examens disponibles	

III-Radiologie:

1- Introduction à la sémiologie radiologique

Question 1 : Les contre-indications absolues de réalisation d'un examen IRM : cocher la réponse fausse : (RF)

(ratt2024)

- A. Les neurostimulateurs
- B. L'obésité
- C. Le pacemaker
- D. Un corps étranger métallique

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Les neurostimulateurs sont une contre-indication absolue à l'IRM (risque de dysfonctionnement, échauffement).
- **B : Faux** — L'obésité n'est pas une contre-indication absolue à l'IRM. Elle peut être une contre-indication relative (problème de diamètre du tunnel, qualité d'image, mais certains IRM ouverts peuvent être utilisés). Ce n'est pas une contre-indication absolue.
- **C : Vrai** — Le pacemaker (non compatible IRM) est une contre-indication absolue.
- **D : Vrai** — Un corps étranger métallique (ferromagnétique, notamment oculaire ou intracrânien) est une contre-indication absolue (risque de migration, échauffement, lésions).

Question 2 : RADIOGRAPHIE THORACIQUE. Cochez la réponse fausse. (RF)

(Pr Manseri ,2025)

- A. Un cliché normal n'exclut pas une cardiopathie..
- B. Arc supérieur droit rectiligne ou légèrement convexe formé par le bord externe de la VCS.
- C. Arc inférieur droit convexe formé par le bord de l'OG.
- D. Arc supérieur gauche correspond à la portion horizontale de la crosse de l'aorte.
- E. Arc moyen gauche est formé par le tronc de l'AP dans ses 2/3 supérieurs et par l'auricule gauche dans son tiers inférieur,

RÉPONSE : C

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Un cliché normal n'exclut pas une cardiopathie (ex : cardiopathie ischémique sans cardiomégalie).
- **B : Vrai** — L'arc supérieur droit est rectiligne ou légèrement convexe, formé par le bord externe de la VCS.
- **C : Faux** — L'arc inférieur droit est convexe, formé par le bord de l'oreillette droite (OD), pas de l'OG. L'OG forme le bord droit en cas de dilatation (double contour).
- **D : Vrai** — L'arc supérieur gauche correspond à la portion horizontale de la crosse de l'aorte.
- **E : Vrai** — L'arc moyen gauche est formé par le tronc de l'AP dans ses 2/3 supérieurs et par l'auricule gauche dans son tiers inférieur.

Question 3 : Le Téléthorax est un :

(2026)

- A. Examen morphologique
- B. L'incidence face standard est antéropostérieure
- C. L'incidence face standard se fait le ventre du patient contre la plaque ; thorax face au rayon
- D. A + B
- E. A + C

RÉPONSE : A

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le téléthorax est un examen morphologique (il étudie la forme et la structure des organes thoraciques).
- **B : Faux** — L'incidence face standard est postéro-antérieure (PA) et non antéro-postérieure (AP). Le patient est dos à la plaque, face au rayon.
- **C : Faux** — L'incidence face standard se fait le dos du patient contre la plaque (incidence PA), et non le ventre. De plus, le thorax est dos au rayon (le rayon traverse le patient de l'arrière vers l'avant).

Question 4 : Parmi les critères de bonne qualité d'un téléthorax :

(2026)

- A. La poche à air gastrique : en inspiration profonde
- B. Au moins 4 vertèbres dorsales visibles : en position debout
- C. Omoplates dégagées
- D. Six arcs costaux antérieurs : bien pénétré
- E. Toutes ces réponses sont justes

RÉPONSE : C

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La poche à air gastrique est un critère de bonne inspiration (elle doit être visible sous la coupole diaphragmatique gauche), pas de "inspiration profonde" en tant que critère de qualité. De plus, la formulation est incorrecte.
- **B : Faux** — Le critère est : au moins 6 vertèbres dorsales visibles à travers le médiastin (ou 10 côtes postérieures), pas 4 vertèbres. Et la position debout est une condition de réalisation, pas un critère de qualité.
- **C : Vrai** — Les omoplates doivent être dégagées (hors des champs pulmonaires) grâce à la rotation des épaules en avant. C'est un critère de qualité du cliché.
- **D : Faux** — Le critère est : 6 arcs costaux antérieurs visibles, mais cela correspond à une bonne pénétration ? Non, les arcs costaux antérieurs visibles correspondent à une bonne inspiration. La "bonne pénétration" se juge sur la visibilité des vertèbres derrière le médiastin.
- **Rappel des critères de qualité du téléthorax :**
 - Symétrique (cliché centré)
 - En position debout
 - En inspiration profonde (6 arcs costaux antérieurs, 10 arcs postérieurs, poche à air gastrique visible)
 - Bien pénétré (vertèbres dorsales visibles à travers le médiastin)
 - Omoplates dégagées (hors des champs pulmonaires)

3- Radio: silhouette cardiaque

Question 5 : RADIOGRAPHIE THORACIQUE. Cochez la réponse fausse. (RF)

(Pr Manseri ,2025)

- A. Chez le sujet bréviline, le cœur apparaît « horizontal ».
- B. Chez le sujet longiline, le cœur est allongé avec un pédicule vasculaire étroit.
- C. Le rapport cardiothoracique (RCT) est pathologique au-delà de 0.55 et l'on parle alors de cardiomegalie.
- D. La dilatation VG importante se traduit par une saillie de l'arc inférieur gauche convexe avec un aspect arrondi de la pointe surélevée.
- E. La trachée se divise en 2 bronches souches qui font normalement un angle aigu; une OG dilatée peut les écarter (signe du cavalier).

RÉPONSE : **D**

4- Radio: autres exploration cardiaque

Question 6 : Le scanner cardiaque est :

(2026)

- A. Examen dynamique
- B. Permet de voir la nécrose myocardique
- C. Analyse les artères coronaires
- D. Est un examen peu irradiant
- E. B + C

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Le scanner cardiaque n'est pas un examen dynamique (c'est un examen statique morphologique).
- **B : Faux** — Le scanner cardiaque ne permet pas de voir la nécrose myocardique. C'est l'IRM cardiaque avec rehaussement tardif qui visualise la nécrose/fibrose myocardique. Le scanner montre la morphologie, les calcifications et les artères coronaires.
- **C : Vrai** — Le scanner cardiaque (coroscaner) analyse les artères coronaires (recherche de sténoses, plaques d'athérome, calcifications).
- **D : Faux** — Le scanner cardiaque est un examen irradiant (rayons X).

5- Echodoppler vasculaire et cardiaque

Question 7 : Que retrouve-t-on à l'écho doppler des membres inférieurs en cas de TVP :

(2026)

- A. Matériel endoluminal à l'intérieur de l'artère
- B. Une veine thrombosée qui ne prend pas le doppler couleur et ne se comprime pas
- C. Une artère thrombosée qui ne se comprime pas
- D. Un flux artériel accéléré
- E. A + C

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La TVP concerne la veine, pas l'artère. Le matériel endoluminal (thrombus) est à l'intérieur de la veine.
- **B : Vrai** — À l'écho-doppler, une veine thrombosée ne prend pas le doppler couleur (absence de flux) et ne se comprime pas (signe de la non-compressibilité veineuse, critère majeur de TVP).
- **C : Faux** — La TVP est une thrombose veineuse, pas artérielle.
- **D : Faux** — Un flux artériel accéléré n'est pas un signe de TVP.

IV-Biochimie:

1- Biochimie de l'homme sain

Question	réponse
Il n'y a pas de QCS à ce cours dans les examens disponibles	

2- Différentes étapes de l'analyse biochimique

Question 1 : Usage des tests biochimiques (RF) :

(Dr Boukhris, ratt2024)

- A. Dépistage et diagnostic
- B. Indication des traitements
- C. Pronostic
- D. Recherche sur la base biochimique des maladies
- E. Essais cliniques des nouveaux médicaments

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Dépistage et diagnostic.
- **B : Faux** — Les tests biochimiques ne servent pas à indiquer les traitements (c'est-à-dire à poser l'indication thérapeutique). Ils servent à surveiller l'efficacité et la tolérance des traitements, mais l'indication thérapeutique est une décision clinique basée sur le diagnostic.
- **C : Vrai** — Pronostic.
- **D : Vrai** — Recherche sur la base biochimique des maladies.
- **E : Vrai** — Essais cliniques des nouveaux médicaments (usage en recherche clinique)

3- Exploration des lipides et lipoprotéines athérogénese

Question 2 : Après centrifugation, l'aspect du sérum peut être indicateur d'une dyslipidémie (RJ)

(Dr Boukhris, ratt2024)

- A. Aspect clair du sérum: bilan lipidique normal
- B. Aspect opalescent :hypercholestérolémie
- C. Aspect lactescent: Hypertriglycéridémie endogène
- D. Aspect opalescent ou lactescent: une origine exogène (chylomicrons)
- E. si anneau crémeux + opalescence du sérum: Chylomicrons + VLDL

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Un aspect clair du sérum n'indique pas forcément un bilan lipidique normal (il peut être normal ou ne pas montrer d'anomalie visible).
- **B : Faux** — Un aspect opalescent évoque une hypertriglycéridémie (VLDL), pas une hypercholestérolémie.
- **C : Faux** — Un aspect lactescent évoque une hypertriglycéridémie exogène (chylomicrons) ou mixte, pas seulement endogène.
- **D : Faux** — Un aspect opalescent ou lactescent peut avoir une origine endogène (VLDL) ou exogène (chylomicrons).
- **E : Vrai** — Un anneau crémeux (chylomicrons) + opalescence du sérum (VLDL) est caractéristique d'une hypertriglycéridémie mixte (chylomicrons + VLDL).

Question 3 : L'athérosclérose évolue sur plusieurs phase (l'affirmation fausse) : (RF)

(Dr Boukhris, ratt2024)

- A. Dépôt des LDL plasmatiques
- B. Recrutement des cellules circulantes: monocytes, lymphocytes T et thrombocytes.
- C. Traumatisme mécanique répété de la paroi artérielle
- D. Recrutement des cellules endothéliales (intima), des cellules musculaires (média) et de la matrice extracellulaire.
- E. Dépôts de caillots de sang et calcifications.

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Dépôt des LDL plasmatiques dans l'intima.
- **B : Vrai** — Recrutement des cellules circulantes : monocytes, lymphocytes T et thrombocytes.
- **C : Faux** — Le traumatisme mécanique répété de la paroi artérielle n'est pas une phase de l'athérosclérose. C'est un facteur favorisant, mais pas une phase évolutive.
- **D : Vrai** — Recrutement des cellules endothéliales (intima), des cellules musculaires (média) et de la matrice extracellulaire.
- **E : Vrai** — Dépôts de caillots de sang et calcifications.

Question 4 : Quel aspect du sérum suggère une hypertriglycéridémie ?

(Dr Boukhris, 2025)

- A. Clair
- B. Opalescent ou lactescent
- C. Jaune pâle
- D. Rougeâtre
- E. Incolore

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Un sérum clair n'évoque pas une hypertriglycéridémie.
- **B : Vrai** — Un aspect opalescent ou lactescent du sérum suggère une hypertriglycéridémie (présence de chylomicrons ou de VLDL).
- **C : Faux** — Un aspect jaune pâle n'est pas spécifique.
- **D : Faux** — Un aspect rougeâtre évoque une hémolyse.
- **E : Faux** — Un aspect incolore n'est pas spécifique.

Question 5 : Quelle est la lipoprotéine considérée comme antiathérogène ?

(Dr Boukhris, 2025)

- A. LDL
- B. VLDL
- C. Chylomicrons
- D. HDL
- E. IDL

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Les LDL sont athérogènes.
- **B : Faux** — Les VLDL sont athérogènes.
- **C : Faux** — Les chylomicrons sont athérogènes (riches en triglycérides).
- **D : Vrai** — Les HDL sont antiathérogènes (transport inverse du cholestérol).
- **E : Faux** — Les IDL sont athérogènes.

Question 6 : Le cholestérol LDL est considéré comme :

(2026)

- A. Anti-athérogène
- B. Athérogène
- C. Neutre
- D. Exclusivement hépatique
- E. Un marqueur de l'immunité

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Le LDL n'est pas anti-athérogène.
- **B : Vrai** — Le cholestérol LDL est considéré comme athérogène (il s'accumule dans la paroi artérielle et favorise l'athérosclérose).
- **C : Faux** — Le LDL n'est pas neutre.
- **D : Faux** — Le LDL n'est pas exclusivement hépatique.
- **E : Faux** — Le LDL n'est pas un marqueur de l'immunité.

4- Biomarqueurs cardiaques

Question 7 : Quel est le marqueur cardiaque qui apparaît le plus tôt après un infarctus du myocarde (IDM) ?

(Dr Boukhris, 2025)

- A. La troponine
- B. La créatine kinase (CK-MB)
- C. La myoglobine
- D. Le proBNP
- E. L'aspartate aminotransférase (ASAT)

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La troponine apparaît plus tardivement (3-6 heures après le début de la douleur).
- **B : Faux** — La CK-MB apparaît vers 4-6 heures.
- **C : Vrai** — La myoglobine est le marqueur le plus précoce (apparaît dès 1-2 heures après l'IDM), mais elle est peu spécifique.
- **D : Faux** — Le proBNP n'est pas un marqueur d'IDM, mais d'insuffisance cardiaque.
- **E : Faux** — L'ASAT n'est pas un marqueur spécifique d'IDM.

Question 8 : Quelles sont les troponines spécifiques au muscle cardiaque ?

(Dr Boukhris, 2025)

- A. Troponine C
- B. Troponine T et C
- C. Troponine I et C
- D. Troponine T et I
- E. Aucune de ces réponse

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La troponine C est commune aux muscles squelettiques et cardiaques.
- **B : Faux** — La troponine T et C : la troponine C n'est pas spécifique du cœur.
- **C : Faux** — La troponine I et C : la troponine C n'est pas spécifique du cœur.
- **D : Vrai** — Les troponines T et I sont spécifiques du muscle cardiaque.

Question 9 : La troponine est :

(2026)

- A. Un marqueur précoce mais non spécifique
- B. Un marqueur spécifique de souffrance myocardique
- C. Une enzyme hépatique
- D. Un peptide natriurétique
- E. Un marqueur de l'insuffisance rénale

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La troponine est spécifique du myocarde, mais elle n'est pas précoce (elle apparaît 3-6 heures après le début de la douleur).
- **B : Vrai** — La troponine est un marqueur spécifique de souffrance myocardique (nécrose).
- **C : Faux** — La troponine n'est pas une enzyme hépatique.
- **D : Faux** — La troponine n'est pas un peptide natriurétique.
- **E : Faux** — La troponine n'est pas un marqueur de l'insuffisance rénale (bien qu'elle puisse être élevée dans l'insuffisance rénale).

Question 10 : Le NT-proBNP est utilisé principalement pour :

(2026)

- A. Le diagnostic de l'infarctus du myocarde
- B. Le suivi de la pancréatite aiguë
- C. Le diagnostic et le pronostic de l'insuffisance cardiaque
- D. Le suivi du diabète sucré
- E. Le diagnostic de l'hypertension artérielle

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Le NT-proBNP n'est pas utilisé pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde.
- **B : Faux** — Le NT-proBNP n'est pas utilisé pour le suivi de la pancréatite aiguë.
- **C : Vrai** — Le NT-proBNP est utilisé pour le diagnostic et le pronostic de l'insuffisance cardiaque.
- **D : Faux** — Le NT-proBNP n'est pas utilisé pour le suivi du diabète sucré.
- **E : Faux** — Le NT-proBNP n'est pas utilisé pour le diagnostic de l'hypertension artérielle.

5- Exploration stress oxydatif

Question 11 : Parmi les proposition quelle sont les antioxydant : (RF)

(Dr Boukhris, 2024)

- A. vitA
- B. vitE
- C. vitB9
- D. vitC
- E. glutathione

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — La vitamine A (rétinol) est un antioxydant.
- **B : Vrai** — La vitamine E (tocophérol) est un antioxydant majeur.
- **C : Faux** — La vitamine B9 (acide folique) n'est pas un antioxydant.
- **D : Vrai** — La vitamine C (acide ascorbique) est un antioxydant.
- **E : Vrai** — Le glutathione est un antioxydant majeur.

Question 12 : Quel est le principal facteur du stress oxydant ?

(Dr Boukhris, 2025)

- A. Excès d'antioxydants
- B. Déséquilibre entre production d'ERO et défenses anti oxydantes.
- C. Manque d'ERO
- D. Faible métabolisme aérobie
- E. Baisse de la production d'anions Superoxyde

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — L'excès d'antioxydants ne cause pas de stress oxydant.
- **B : Vrai** — Le stress oxydant résulte d'un déséquilibre entre la production d'espèces réactives de l'oxygène (ERO) et les défenses antioxydantes.
- **C : Faux** — Le manque d'ERO ne cause pas de stress oxydant.
- **D : Faux** — Le faible métabolisme aérobie ne cause pas de stress oxydant.
- **E : Faux** — La baisse de production d'anion superoxyde ne cause pas de stress oxydant.

Question 13 : Quel est le radical libre oxygéné le plus réactif ?

(Dr Boukhris, 2025)

- A. L'anion Superoxyde ($O_2^{\cdot-}$)
- B. Le monoxyde d'azote ($NO\cdot$)
- C. Le radical hydroxyle ($HO\cdot$)
- D. Le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2)
- E. L'acide hypochloreux ($HOCl$)

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — L'anion superoxyde ($O_2^{\cdot-}$) est moins réactif que le radical hydroxyle.
- **B : Faux** — Le monoxyde d'azote ($NO\cdot$) est moins réactif.
- **C : Vrai** — Le radical hydroxyle ($HO\cdot$) est le radical libre oxygéné le plus réactif (demi-vie très courte, réactivité extrême).
- **D : Faux** — Le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) n'est pas un radical libre (c'est une espèce réactive de l'oxygène).
- **E : Faux** — L'acide hypochloreux ($HOCl$) est moins réactif que le $HO\cdot$.

Question 14 : Le stress oxydant résulte :

(2026)

- A. D'un excès d'antioxydants
- B. D'un déficit en oxygène
- C. D'un déséquilibre entre ERO et défenses antioxydantes
- D. D'une hyperglycémie
- E. D'une carence en fer

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Un excès d'antioxydants ne cause pas de stress oxydant.
- **B : Faux** — Un déficit en oxygène ne cause pas directement un stress oxydant.
- **C : Vrai** — Le stress oxydant résulte d'un déséquilibre entre les espèces réactives de l'oxygène (ERO) et les défenses antioxydantes.
- **D : Faux** — L'hyperglycémie peut favoriser le stress oxydant, mais ce n'est pas la définition.
- **E : Faux** — La carence en fer peut favoriser le stress oxydant, mais ce n'est pas la définition.

Question 15 : Le radical hydroxyle ($HO\cdot$) peut être formé par :

(2026)

- A. Réaction de Fenton
- B. Réaction de Haber-Weiss
- C. Radiations ionisantes
- D. Toutes les réactions ci-dessus
- E. Aucune réponse

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — La réaction de Fenton ($Fe^{2+} + H_2O_2 \rightarrow Fe^{3+} + HO\cdot + OH^-$) forme le radical hydroxyle.
- **B : Vrai** — La réaction de Haber-Weiss ($O_2^{\cdot-} + H_2O_2 \rightarrow O_2 + HO\cdot + OH^-$) forme le radical hydroxyle.
- **C : Vrai** — Les radiations ionisantes (radiolyse de l'eau) forment le radical hydroxyle.
- **D : Vrai** — Toutes ces réactions forment le radical hydroxyle.

Question 16 : L'anion superoxyde (O_2^-) provient principalement :

(2026)

- A. De la glycolyse
- B. De la chaîne respiratoire mitochondriale
- C. Du cycle de Krebs
- D. De la bêta-oxydation
- E. De la synthèse protéique

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La glycolyse ne produit pas directement d'anion superoxyde.
- **B : Vrai** — L'anion superoxyde provient principalement de la chaîne respiratoire mitochondriale (fuite d'électrons au niveau des complexes I et III).
- **C : Faux** — Le cycle de Krebs ne produit pas directement d'anion superoxyde.
- **D : Faux** — La bêta-oxydation ne produit pas directement d'anion superoxyde.
- **E : Faux** — La synthèse protéique ne produit pas d'anion superoxyde.

V-Psychologie:

1- L'entretien psychiatrique

Question 1 : Dans la relation Médecin- Malade, le médecin doit : (RF)

(Pr Djaouadi, ratt2024)

- A. Être attentif.
- B. Une présence simplement physique.
- C. Être disponible, entièrement pendant l'examen.
- D. Être compréhensif.
- E. Pouvoir saisir la signification des symptômes du patient.

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Être attentif.
- **B : Faux** — Le médecin ne doit pas avoir une présence simplement physique. Il doit être présent psychiquement et physiquement (écoute active, empathie, disponibilité mentale).
- **C : Vrai** — Être disponible, entièrement pendant l'examen.
- **D : Vrai** — Être compréhensif.
- **E : Vrai** — Pouvoir saisir la signification des symptômes du patient.

Question 2 : Dans la relation Médecin- Malade, le médecin doit : (RF)

(Pr Djaouadi, 2025)

- A. Être Inattentif.
- B. Présent psychiquement et physiquement..
- C. Être disponible, entièrement pendant l'examen.
- D. Être compréhensif..
- E. Pouvoir saisir la signification des symptômes du patient

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **a : Faux** — Le médecin ne doit pas être inattentif. Il doit être attentif.
- **b : Vrai** — Présent psychiquement et physiquement.
- **c : Vrai** — Être disponible, entièrement pendant l'examen.
- **d : Vrai** — Être compréhensif.
- **e : Vrai** — Pouvoir saisir la signification des symptômes du patient.

2- PSYCHOSOMATIQUE

Question	réponse
Il n'y a pas de QCSs à ce cours dans les examens disponibles	

3- LE STRESS EN PSYCHIATRIE

Question	réponse
Il n'y a pas de QCSs à ce cours dans les examens disponibles	

4- ANNONCE D'UNE MALADIE GRAVE

Question 3 : Concernant les représentations que le malade se forge de sa maladie, celles-ci peuvent comprendre plusieurs dimensions dont : (RJ)

(Pr Djaouadi, 2025)

1. la place donnée à la maladie dans l'histoire du sujet..
2. l'intégration familiale de la maladie
3. les modifications de l'image de soi.
4. la conception de la guérison,
5. Les représentations sociales et culturelles liées à la maladie en général et à sa maladie en particulier.

- A. 1 + 2 + 3
B. 1 + 3 + 4
C. 1 + 2 + 5
D. 1 + 2 + 3 + 4
E. 1 + 2 + 3 + 4 + 5

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **1 : Vrai** — La place donnée à la maladie dans l'histoire du sujet.
- **2 : Vrai** — L'intégration familiale de la maladie.
- **3 : Vrai** — Les modifications de l'image de soi.
- **4 : Vrai** — La conception de la guérison.
- **5 : Vrai** — Les représentations sociales et culturelles liées à la maladie en général et à sa maladie en particulier.
- **E : Vrai** — Toutes ces dimensions sont correctes.

Question 4 : L'annonce d'un diagnostic grave est suivie à la phase initiale du choc par une période de sidération, puis d'une période de décharge émotionnelle; cette dernière est caractérisée par toutes ces propositions sauf une, laquelle ? (RF)

(Pr Djaouadi, 2025)

- A. Une tristesse.
B. Une expression d'un désespoir avec une idéation et des propos suicidaires.
C. Un refus, une révolte, une colère et des sentiments d'injustice..
D. Une euphorie et une exaltation de l'humeur..
E. Une symptomatologie psychotique aiguë.

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Une tristesse.
- **B : Vrai** — Une expression d'un désespoir avec une idéation et des propos suicidaires.
- **C : Vrai** — Un refus, une révolte, une colère et des sentiments d'injustice.
- **D : Faux** — Une euphorie et une exaltation de l'humeur ne font pas partie de la période de décharge émotionnelle. C'est plutôt l'inverse (tristesse, désespoir, révolte).
- **E : Vrai** — Une symptomatologie psychotique aiguë.

Question 5 : Parmi les principaux mécanismes de défense observés dans la situation d'annonce d'une maladie grave, on retrouve : (RJ)

(Pr Djaouadi, 2025)

1. Le déni.
2. Le déplacement
3. L'Intellectualisation et la rationalisation
4. La banalisation et la minimisation.
5. La projection.

- A. 1 + 2 + 3
B. 1 + 2 + 4
C. 1 + 2 + 5
D. 1 + 2 + 3 + 5
E. 1 + 2 + 3 + 4 + 5

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **1 : Vrai** — Le déni.
- **2 : Vrai** — Le déplacement.
- **3 : Vrai** — L'intellectualisation et la rationalisation.
- **4 : Vrai** — La banalisation et la minimisation.
- **5 : Vrai** — La projection.
- **E : Vrai** — Tous ces mécanismes de défense peuvent être observés.

5- Aspects communicationnels de la rencontre avec le malade et sa famille

Question 6 : Transfert positif : (RJ)

(2026)

- A. Le patient éprouve de l'amour, de la reconnaissance envers le médecin.
- B. Le patient éprouve de la haine, de la colère, du dépit envers le médecin.
- C. Le médecin éprouve de l'amour, de la reconnaissance envers le patient.
- D. Le médecin éprouve de la haine, de la colère, du dépit envers le patient.
- E. Le patient éprouve de l'indifférence envers le médecin.

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le transfert positif est un mécanisme psychologique où le patient éprouve des sentiments positifs (amour, reconnaissance, admiration) envers le médecin, souvent en lien avec des figures parentales ou affectives de son passé.
- **B : Faux** — Le transfert négatif correspond à des sentiments de haine, colère ou dépit envers le médecin.
- **C : Faux** — Le contretransfert concerne les sentiments du médecin envers le patient.
- **D : Faux** — Le contretransfert négatif concerne les sentiments négatifs du médecin envers le patient.
- **E : Faux** — L'indifférence n'est pas caractéristique du transfert positif.
- **Rappel :**
 - Transfert = sentiments du patient envers le médecin.
 - Contretransfert = sentiments du médecin envers le patient.
 - Transfert positif = amour, reconnaissance, admiration.
 - Transfert négatif = haine, colère, dépit.

6- Fonctionnement de la personnalité

Question 7 : La personnalité est : (RF)

(Pr Bait, 2025)

- A. Une unité intégrative.
- B. Une structure instable, possédant une certaine constance.
- C. Une structure autonome.
- D. Dynamique qui fait de chaque individu un sujet unique.
- E. Constituée du tempérament, du caractère et de l'intelligence.

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **a : Vrai** — Elle est une unité intégrative (intègre les différentes dimensions de l'individu).
- **b : Faux** — La personnalité est une structure stable (et non instable), possédant une certaine constance dans le temps. C'est cette stabilité qui permet de reconnaître un individu comme étant "lui-même" à travers les situations et le temps.
- **c : Vrai** — Elle est une structure autonome.
- **d : Vrai** — Elle est dynamique et fait de chaque individu un sujet unique.
- **e : Vrai** — Elle est constituée du tempérament, du caractère et de l'intelligence.

Question 8 : Le tempérament : (RJ)

(2026)

- A. Représente l'aspect biologique, inné et stable de la personnalité.
- B. Représente l'aspect biologique, acquis et stable de la personnalité.
- C. Représente l'aspect biologique, inné et instable de la personnalité.
- D. Représente l'aspect biologique, acquis et instable de la personnalité.
- E. Représente l'aspect social, variant au cours du temps.

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le tempérament représente l'aspect biologique, inné (héréditaire) et stable de la personnalité (émotivité, activité, réactivité).
- **B : Faux** — Le tempérament est inné, pas acquis.
- **C : Faux** — Le tempérament est stable, pas instable.
- **D : Faux** — Le tempérament est inné et stable, pas acquis et instable.
- **E : Faux** — Le tempérament est biologique et inné, pas social et variant.

7- Psychologie de la douleur et prise en charge

Question 9 : La douleur psychogène : (RF)

(Pr Bait, 2025)

- A. Elle est périphérique.
- B. Elle est d'évocation tardive,
- C. Les bilans cliniques et paracliniques sont positifs
- D. Repose sur une sémiologie psychopathologique positive.
- E. Répond à la psychothérapie

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **a : Vrai** — Elle est périphérique (exprimée par le patient, mais sans substrat organique).
- **b : Vrai** — Elle est d'évocation tardive (après élimination des causes organiques).
- **c : Faux** — Les bilans cliniques et paracliniques sont négatifs (pas de lésion organique retrouvée). C'est un diagnostic d'élimination.
- **d : Vrai** — Repose sur une sémiologie psychopathologique positive (troubles anxieux, dépressifs, etc.).
- **e : Vrai** — Répond à la psychothérapie.

Question 10 : La douleur psychogène : (RJ)

(2026)

- A. Elle est centrale.
- B. Elle est d'évocation précoce.
- C. Les bilans cliniques et paracliniques sont positifs.
- D. Repose sur une sémiologie psychopathologique négative.
- E. Répond à la psychothérapie.

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La douleur psychogène n'est pas centrale (elle est périphérique dans son expression).
- **B : Faux** — Elle est d'évocation tardive (après élimination des causes organiques), pas précoce.
- **C : Faux** — Les bilans cliniques et paracliniques sont négatifs.
- **D : Faux** — Elle repose sur une sémiologie psychopathologique positive (et non négative).
- **E : Vrai** — Elle répond à la psychothérapie.

8- Psychologie de la prescription

Question 11 : Quelles sont les causes qui expliquent la mauvaise observance thérapeutique : (RF)

(Pr Bait, ratt2024, 2025)

- A. Les effets indésirables du traitement.
- B. La croyance en l'efficacité ou l'inefficacité de son traitement par le patient.
- C. Le délai d'action des traitements.
- D. La couleur, la taille, le goût, le nom des médicaments.
- E. La bonne relation Médecin- Malade.

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Les effets indésirables du traitement.
- **B : Vrai** — La croyance en l'efficacité ou l'inefficacité de son traitement par le patient.
- **C : Vrai** — Le délai d'action des traitements.
- **D : Vrai** — La couleur, la taille, le goût, le nom des médicaments.
- **E : Faux** — Une bonne relation médecin-malade est un facteur d'amélioration de l'observance, pas une cause de mauvaise observance. La mauvaise observance est favorisée par une mauvaise relation médecin-malade.

Question 12 : Quelles sont les causes qui expliquent la mauvaise observance thérapeutique : (RF)

(2026)

- A. L'absence des effets indésirables du traitement.
- B. La croyance en l'efficacité ou l'inefficacité de son traitement par le patient.
- C. Le délai d'action des traitements.
- D. La couleur, la taille, le goût, le nom des médicaments.
- E. La mauvaise relation Médecin-Malade.

RÉPONSE : A

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — L'absence d'effets indésirables n'est pas une cause de mauvaise observance. Au contraire, la présence d'effets indésirables est une cause de mauvaise observance.
- **B : Vrai** — La croyance en l'efficacité ou l'inefficacité de son traitement par le patient.
- **C : Vrai** — Le délai d'action des traitements.
- **D : Vrai** — La couleur, la taille, le goût, le nom des médicaments.
- **E : Vrai** — La mauvaise relation Médecin-Malade.